Akademin för hälsa, vård och välfärd

BIOPSYKOSOCIALA EFFEKTER AV FYSIOTERAPEUTISKA INTERVENTIONER HOS KVINNOR MED POSTPARTUM DEPRESSION

En systematisk litteraturstudie

ANNA NÖJD
HANNA MÖLLING

Huvudområde: Fysioterapi
Nivå: Grundnivå
Högskolepoäng: 15 hp
Program: Fysioterapeutprogrammet
Kursnamn: Examensarbete med inriktning mot beteendemedicin
Kurskod: FYS063

Handledare: Anna Ullenhag
Examinator: Sebastian Lindblom

Seminariedatum: 2026-02-18
Betygsdatum: 2026-04-14

Sammanfattning:

Bakgrund: Postpartum depression är ett folkhälsoproblem som inte bara drabbar kvinnan, utan påverkar även övriga familjemedlemmar. Det finns idag begränsad evidens gällande fysioterapeutiska interventioner då befintlig forskning fokuserar mer på psykologisk behandling. Fysioterapeutiska interventioner i from av fysisk aktivitet har en genomgående trend att minska depressiva symtom. För att belysa biopsykosociala faktorer tillämpas social kognitiva teorin som fokuserar på individ, omgivning och beteende.

Syfte: Denna systematiska litteraturstudie undersökte vilka biopsykosociala effekter fysioterapeutiska interventioner avseende fysisk aktivitet har för kvinnor med postpartum depression.

Metod: Systematisk litteraturstudie med artiklar från PubMed och CINAHL. Fem randomiserade kontrollerade studier (RCT) och en RCT-pilotstudie inkluderades. Studierna kvalitetsgranskades med SBU:s mall.

Resultat: Studiernas interventioner varierade, men bestod främst av aerob träning på måttlig intensitet. Interventionerna varade mellan 4-12 veckor. Tre av sex studier visade statisk signifikanta skillnader gällande depressiva symtom i mellangruppsjämförelse. Samtliga studier uppvisade måttlig till hög risk för bias vilket begränsar den preliminära evidensstyrkan.

Slutsats: Fysioterapeutiska interventioner i form av fysisk aktivitet kan påverka biopsykosociala faktorer såsom minskade depressiva symtom hos kvinnor med PPD. Däremot bör resultaten tolkas med försiktighet på grund av hög risk för bias och begränsad generaliserbarhet.

Nyckelord: Beteendemedicin. Depressiva symtom. Fysioterapi. Fysisk aktivitet. Fysisk träning.

Abstract:

Background: Postpartum depression is a public health problem that not only affects the woman but also impacts other family members. Currently there´s limited evidence regarding physiotherapeutic interventions, as existing research has primarily focused on psychological treatments. Physiotherapeutic intervention in the form of physical activity show a consistent trend toward reducing depressive symptoms. To highlight biopsychosocial factors, social cognitive theory is applied, focusing on the interaction between the individual, the environment and behavior.

Aim: This systematic literature review investigated the biopsychosocial effects of physiotherapeutic interventions involving physical activity in women with postpartum depression.

Methods: A systematic literature review was conducted using articles retrieved from PubMed and CINAHL. Five randomized controlled trails (RCT) and one RCT pilot study were included. The studies were quality assessed using the SBU review template.

Results: The interventions varied across studies but primarily consisted of moderate-intensity aerobic exercise. Intervention durations ranged from 4-12 weeks. Three out of six studies showed statistically significant differences regarding depressive symptoms in between-group comparison. All studies showed a moderate to high risk of bias, which limits the preliminary strength of the evidence.

Conclusion: Physiotherapeutic interventions involving physical activity may influence biopsychosocial factors by reducing depressive symptoms in women with PPD. The results should be interpreted with caution due to the high risk of bias and limited generalizability.

Keywords: Behavioral medicine. Depressive symptoms. Exercise Physiotherapy. Physical activity.

INNEHÅLL

1 Bakgrund 1

1.1 Postpartum depression 1

1.1.1 Riskfaktorer och orsaker till PPD 1

1.1.2 Diagnostik PPD 2

1.1.3 Konsekvenser av PPD 2

1.1.4 Behandling vid PPD 3

1.2 Fysioterapeutiska interventioner 4

1.2.1 Fysisk träning 4

1.2.2 Fysisk aktivitet efter förlossning 4

1.2.3 Yoga 5

1.3 Fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning 6

1.4 Socialkognitiva teorin kopplat till PPD 6

1.5 Problemformulering 8

2 Syfte 8

2.1 Frågeställning 8

3 Metod 9

3.1 Design 9

3.2 Urval 9

3.2.1 Inklusionskriterier 9

3.2.2 Exklusionskriterier 10

3.3 Litteratursökning 10

3.3.1 PICO 12

3.3.2 Relevansbedömning 12

3.3.3 Dataextraktion 13

3.4 Kvalitetsgranskning 13

3.4.1 Utvärderingsinstrument 14

3.5 Preliminär evidensgradering 14

3.6 Etik 14

4 Resultat 15

4.1 Urvalsprocessen 15
4.2 Sammanfattning av inkluderade studier 15
4.3 Beskrivning av inkluderade studier 16
4.4 Studiernas interventionsinnehåll 19
4.4.1 Buttner et al. (2015) 19
4.4.2 Da Costa et al. (2009) 19
4.4.3 Daley et al. (2008) 20
4.4.4 Dritsa et al. (2008) 20
4.4.5 Forsyth et al. (2017) 20
4.4.6 Özkan et al. (2020) 21
4.5 Utvärderingsinstrument och utfallsmått 21
4.5.1 Primära utvärderingsinstrument och utfallsmått 21
4.5.2 Sekundära utvärderingsinstrument och utfallsmått 22
4.6 Utfall och effekter av fysioterapeutiska interventioner på PPD 22
4.6.1 Buttner et al. (2015) 23
4.6.2 Da Costa et al. (2009) 23
4.6.3 Daley et al. (2008) 23
4.6.4 Dritsa et al. (2008) 24
4.6.5 Forsyth et al. (2017) 24
4.6.6 Özkan et al. (2020) 24
4.7 Studiekvalitet 25
4.8 Preliminär evidensstyrka 26
5 Diskussion 26
5.1 Resultatsammanfattning 26
5.2 Resultatdiskussion 26
5.3 Metoddiskussion 30
5.4 Etikdiskussion 33
6 Slutsatser 33
7 Klinisk Betydelse och vidare forskning 34

BILAGA A- SBU:S MALL FÖR RELEVANSBEDÖMNING

BILAGA B- ROB2

BILAGA C- PUBMED MESH-SÖKNINGAR

1 BAKGRUND

1.1 Postpartum depression

I Sverige och globalt drabbas cirka 13%-17% av alla kvinnor av postpartumdepression (PPD) under de första månaderna efter förlossningen enligt (SBU 2022; Qi et al. 2025). PPD är ett globalt folkhälsoproblem hos kvinnor och det vanligaste perinatala psykiska tillståndet. PPD ger symtom som nedstämdhet, anhedoni vilket innebär ”Oförmåga att uppleva njutning på grund av dysfunktion i normala psykologiska och neurologiska mekanismer.” (Svensk MeSH, u.å.) samt brist på glädje. För att hantera symtomen och minska lidandet erbjuds olika former av behandling beroende på svårighetsgrad och kvinnans individuella behov. Vanligast är psykologiska behandlingar och läkemedel men fysisk aktivitet kan eventuellt också vara ett alternativ (Qi et al., 2025).

1.1.1 Riskfaktorer och orsaker till PPD

Det är inte klarlagt vad som orsakar PPD, vilket gör att förebyggande insatser är svåra att vidta (Qi et al., 2025). Men det finns flera riskfaktorer för att utveckla PPD, vilket inkluderar tidigare depressioner, brist på socialt stöd, hälsoproblem hos barnet, relationsproblem, våld i nära relationer, tidigare svåra livshändelser eller trauman (Stewart & Vigod, 2019). Riskfaktorer för PPD inkluderar även sociodemografiska faktorer såsom låg utbildningsnivå och socioekonomisk status, även depression eller ångest före förlossningen kan också öka risken att drabbas av PPD (Walker et al., 2021).

Patofysiologin bakom PPD är komplex och ännu inte helt klarlagd (Stewart & Vigod, 2019). Det finns dock evidens för att biologiska faktorer, såsom hormoner, genetik och immunsystemet kan ha betydande inverkan. Östrogen och progesteron är två hormoner som har studerats i samband med PPD. Dessa hormoner förändras både under och efter graviditet och påverkar känslomässig bearbetning, vakenhet, kognition och motivation. De reglerar även sköldkörtelfunktion, hypotalamus-hypofys-binjureaxeln (HPA-axeln), immunsystem och genuttryck, vilka är alla system som bidrar till uppkomsten av egentlig depression (Stewart & Vigod, 2019).

Stewart & Vigod (2019) beskriver att genetiska faktorer har visat sig vara kopplade till PPD. Den ärftliga risken har påvisats i studier på familjer och tvillingar. Immunsystemet påverkas dessutom under den perinatala perioden, då östrogennivåerna varierar kraftigt. Efter förlossningen övergår däremot moderns immunsystem till ett mer proinflammatoriskt tillstånd som kan vara i flera veckor enligt Stewart & Vigod (2019). Studier har visat att

kvinnor med PPD verkar ha ett förändrat genuttryck kopplat till immunsystemet. Däremot har forskningen ännu inte kunnat påvisa vilka prenatala immunmarkörer som är kopplade till PPD, vilket försvårar fastställandet om immunsystemets roll vid PPD (Stewart & Vigod, 2019).

1.1.2 Diagnostik PPD

Det är av betydelse att kunna diagnostisera PPD tidigt, Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) är ett självskattningsformulär bestående av 10 frågor, utvecklat av Cox et al. (1987) för att identifiera kvinnor med symtom på PPD som bör utredas vidare. EPDS har god validitet, reliabilitet och är känsligt för förändring över tid. Ett resultat på 12–13 poäng eller högre motiverar en ytterligare klinisk bedömning av depressiva symtom. EPDS ersätter inte en klinisk bedömning utan är till hjälp för vårdpersonal att identifiera kvinnor som eventuellt har PPD. Poäng strax under gränsvärdet utesluter inte PPD om det finns andra skäl att misstänka att psykisk ohälsa föreligger. Kvinnor som får en poäng på 9–10 kan vara lämpliga för en rutinmässig screening, detta för att öka känsligheten och minska risken för att missa fall av PPD (Cox et al., 1987).

Hamilton Rating Scale for Depression (HAMD eller HDRS) är en av de mest frekvent använda skalorna för att mäta och diagnostisera depression. Skalan omfattar 21 frågor varav 17 ingår i den totala poängen. Frågorna fokuserar på depressionens beteendemässiga egenskaper samt flera somatiska symtom såsom energi, aptit och viktförändringar (Ross et al., 2003). I en studie av Gerbasi et al. (2020) undersöktes om HAMD kan användas vid PPD. Studien kom fram till att poängen i självrapporterade mått som EPDS och Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) korrelerar starkt med HAMD som är en klinikerrapporterad skattningsskala. Studien visade också måttlig överensstämmelse i remission, vilket innebär att symtomen har minskat så pass mycket att de inte längre uppfyller kriterierna för PPD, vilket definieras genom ett gränsvärde för respektive skala.

1.1.3 Konsekvenser av PPD

PPD kan även få negativa följder för partnern och samhället i stort (Qi et al., 2025). Enligt en systematisk översikt av Slomian et al. (2019) som sammanställde konsekvenserna av PPD för modern och barnet, visade resultaten att mödrar med PPD hade sämre fysisk hälsa och lägre livskvalitet. Den visade också att mödrar med PPD i högre grad sökte vård för medicinska orsaker, vilket tyder på högre vårdkostnader jämfört med icke-deprimerade kvinnor. Dessutom har bristande sociala relationer och en försämrad relation till partnern identifierats som ytterligare konsekvenser av PPD.

När det gäller barnets hälsa (0–3 år) visade resultaten att PPD gav olika konsekvenser beroende på om studierna genomfördes i hög- eller låginkomstländer. I låginkomstländer hade barn till mödrar med PPD sämre viktuppgång och tecken på tillväxthämning. Sambandet var betydligt svagare i höginkomstländer, där det däremot sågs ett samband mellan PPD och sämre kognitiv utveckling hos barnet. PPD kunde också kopplas till negativa

effekter på barnets språkliga, emotionella, sociala och beteendemässiga utveckling, samt även försämrad allmän hälsa och sömnkvalitet enligt Slomian et al. (2019). Vidare visade de flesta studier ett tydligt samband mellan PPD och en försämrad vård av barnet, vilket yttrade sig i bristande omsorg, svårigheter med anknytning till modern och otrygga relationer. PPD kan även leda till anknytningsproblem mellan barnet och modern, till följd av bristande fysisk närhet eller moderns känslomässiga frånvaro vid PPD (Slomian et al., 2019).

1.1.4 Behandling vid PPD

På grund av de allvarliga konsekvenserna som PPD kan innebära är det av största betydelse att behandling erbjuds. Vid PPD erbjuds olika psykologiska behandlingar och läkemedel. I Sverige inleds vården av PPD med personcentrerade stödsamtal där man sedan kan remitteras vidare vid behov. Då kan behandlingen bestå av kognitiv beteendeterapi (KBT) eller interpersonell terapi (IPT) vilket är de behandlingar som rekommenderas av Socialstyrelsen för lindrig till måttlig depression (SBU, 2022a). IPT är en manualbaserad behandlingsmetod som grundar sig på att depression oavsett etiologi, vidmakthålls i ett interpersonellt sammanhang. Man vill uppnå en symtomlindring genom att fokusera på relationella problem kopplade till förlust, förändringar eller konflikter. Detta genom att förstå samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Särskilt fokus läggs på kommunikation, socialt stöd och interpersonell funktion (Dennis et al., 2012). KBT syftar till att förändra maladaptiva tankemönster och beteenden som upprätthåller psykisk ohälsa. Centrala komponenter innefattar kognitiv omstrukturering vilket innebär att identifiera och förändra negativa tankar. Även beteendeaktivering är en del av KBT som syftar till att öka meningsfulla aktiviteter för att stärka välbefinnandet (Li et al., 2022). Enligt SBU (2022a) föredrar kvinnor med PPD olika psykologiska och psykosociala behandlingar framför läkemedelsbehandling. KBT minskar depressiva symtom i måttlig grad både direkt efter avslutande behandling och upp till sex månader senare med måttlig tillförlitlighet. IPT ger större symtomlindring direkt efter behandling, medan stödjande samtal har effekt på längre sikt, ca 6 månader efter behandlingen vilket har påvisats med låg tillförlitlighet. Kvinnornas upplevelse av behandlingen för PPD påverkas av deras förutsättningar och förväntningar, men generellt var kvinnorna nöjda med behandlingen (SBU, 2022a).

Även psykosociala interventioner har effekt på PPD och minskar de depressiva symtomen. Exempel på sådana interventioner är kamratstöd, vilket innebär emotionellt, utvärderande och informativt stöd från personer med erfarenheter av PPD. Delat föräldraskap eller Co-parenting är en annan psykosocial intervention där man fokuserar på samarbetet mellan föräldrarna i barnomsorgen, oberoende av föräldrarnas parrelation vilket minskar risk för PPD hos båda föräldrarna (Dennis et al., 2024).

Dennis et al. (2024) skriver att fysisk träning som behandlingsalternativ för PPD är effektivt och leder till en signifikant minskning av depressiva symtom. Det är också ett uppskattat behandlingsalternativ hos många kvinnor, då många föredrar interventioner som inte är farmakologiska. Rekommendationerna är 20–30 minuters måttlig träning dagligen. Större effekt av fysisk träning har påvisats vid över 150 minuters träning i veckan. Trots den evidens

som finns för fysisk aktivitet vid PPD är de biopsykosociala effekterna av fysioterapeutiska interventioner ännu inte klarlagda. Särskilt saknas kunskap om hur olika interventioner, intensitet och faktorer som förlossningssätt, komplikationer och samsjuklighet påverkar psykiska, fysiska och sociala utfall hos kvinnor med PPD (Deprato et al., 2025).

1.2 Fysioterapeutiska interventioner

Fysisk träning, fysisk aktivitet och yoga är centrala fysioterapeutiska interventioner som har visat positiva effekter på både fysisk och psykisk hälsa hos kvinnor efter förlossning. Genom olika biopsykosociala mekanismer kan dessa insatser bidra till minskade depressiva symtom och förbättrat välbefinnande vid PPD (Deprato et al., 2025).

1.2.1 Fysisk träning

Fysisk träning definieras som ”aktivitet som kräver fysisk ansträngning, utförd för att upprätthålla eller förbättra hälsa eller kondition” (Govindaraj et al., 2016). Syftet med träning är alltså att upprätthålla eller förbättra kroppsliga funktioner, främst kardiovaskulära och neuromuskulära egenskaper. Beroende på vilket energisystem som används i kroppen kan träningen klassificeras som aerob, träning med tillgång till syre eller anaerob träning utan tillgång till syre, eller en kombination av båda dessa former. Det finns tre olika typer av träning isoton/dynamisk träning där rörelse och muskelfibrernas längd förändras under kontraktionen, eller så kan träningen ske statiskt/isometrisk där muskellängden inte förändras utan är konstant. Det kan även ske en kombination av båda formerna. Fysisk träning har positiva effekter på flera kroppsliga system såsom det kardiorespiratoriska och endokrina systemet. Träning ökar frisättning av tillväxtfaktorer som Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), stärker immunförsvaret och minskar kronisk inflammation när träningen utförs på en måttlig nivå (Govindaraj et al., 2016).

1.2.2 Fysisk aktivitet efter förlossning

Fysisk aktivitet ”definieras, rent fysiologiskt, som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver den energiförbrukning vi har i vila” (FYSS, 2016). Pulshöjande och muskelstärkande fysisk aktivitet minst 150 minuter per vecka är den nuvarande rekommendationen för gravida kvinnor. Gravida kvinnor som är fysiskt aktiva känner ofta mindre stress, ångest och depression (FYSS, 2021). Men det är viktigt att belysa att varje kvinna är unik och därför rekommenderas individanpassad träning. Genom att vara fortsatt fysiskt aktiv efter förlossning kan välbefinnandet öka och risken för depression minska (FYSS, 2021).

I en metaanalys av Deprato et al. (2025) undersöktes olika träningsinterventioner och deras effekt på att minska depressiva symtom och ångest efter förlossning samt om träning kan minska risk för att depressiva symtom ska utvecklas till PPD. I studien kom man fram till att

olika typer av träningsinterventioner som aerob träning, yoga, kombinerad träning av styrka och kondition samt stretching minskade depressiva symtom hos kvinnorna efter förlossning samt minskade risken för att utveckla PPD. Man såg också att bäckenbottenträning inte hade någon signifikant effekt på att minska depressiva symtom. Effekten var störst om träningen påbörjades under de 3 första månaderna efter förlossningen. Den rekommenderade doseringen för att nå en måttlig minskning av depressiva symtom enligt studien är minst 350 MET-min/vecka minst fyra gånger i veckan. Detta kan exempelvis motsvara ungefär 80 minuters träning på måttlig intensitet per vecka. De positiva effekterna på depressiva symtom och minskad risk för att utveckla PPD kan förklaras av psykologiska och biologiska mekanismer. Där man bland annat ser att förbättringarna beror på ökad självkänsla, minskad stress och förbättrad coping. Men också ökade serotonin och dopaminnivåer, minskat kortisol samt minskad inflammation (Deprato et al., 2025).

1.2.3 Yoga

Yoga är en annan form av fysisk aktivitet som förekommer som behandling för PPD och som har liknande effekter som andra träningsformer (de Manincor et al., 2016). Yoga kan betraktas som ett holistiskt och flerdimensionellt system för hälsa och välbefinnande genom att integrera kropp och själ. Praktiken innefattar flera komponenter, däribland olika fysiska kroppsställningar, rörelser, andningsövningar, avslappning, mindfulness och meditation. Även främjandet av positiva värderingar, tankemönster och livsstilsvanor ingår i utövandet. Yoga främjar både fysisk och psykisk hälsa och används som ett komplement till konventionella behandlingsmetoder för depression och ångest (de Manincor et al., 2016). Syftet med yoga som behandlingsform är inte enbart att behandla en psykisk sjukdom, utan att stödja en mer övergripande psykisk och fysisk hälsa. Studier har visat på att yoga har en positiv effekt på ångest och depression, men resultaten uppvisar variation. Vilket delvis kan förklaras av de skiftande tillvägagångssätten och utformningen av olika yogainterventioner (de Manincor et al., 2016). Enligt Deprato et al. (2025) minskar yoga depressiva symtom hos postpartumkvinnor samt risken för att utveckla PPD. Evidensen för detta ansågs som måttlig då resultaten varierade något mellan studierna, och vissa fynd var baserade på små urval. Effekter av regelbunden yoga är enligt Govindaraj et al. (2016) både en minskad trötthet och sympatisk överaktivitet. Övergång i en parasympatisk dominans leder till fysiologiska effekter som avslappning, förbättrar immunförsvar, hormonell balans, lägre kortisolnivåer, ökade nivåer av serotonin, GABA och BDNF vilket främjar neuroplasticitet och emotionell stabilitet.

De grundläggande principerna för yoga och fysisk träning visar att båda bygger på synsätt som omfattar fysiska, psykologiska och sociala aspekter av hälsa och livskvalitet. Yogans tvärvetenskapliga ansats kan därför bidra och vara ett bra komplement och kan implementeras i fysioterapeutisk praxis. Yoga kan då bidra till att påverka flera dimensioner av hälsa, däribland stärka emotionellt välbefinnande, kognitiva funktioner och motivation (Posadzki & Parekh, 2009).

1.3 Fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning

Fysioterapeuter har en betydande roll i att främja hälsa och minska ohälsa både vid fysiska besvär och psykiska tillstånd. Fysioterapi utgör en viktig kompletterande behandlingsmetod vid depression och kan delvis kompensera för begränsad psykoterapi och läkemedel. Flera fysioterapeutiska interventioner har visats minska depressiva symtom och kan uppvisa effekter jämförbara med antidepressiva läkemedel (Liu et al., 2024).

Beteendemedicin innebär ett helhetsperspektiv där sociokulturella, psykosociala, beteendemässiga och biomedicinska faktorer integreras i bedömning och behandling (Denison & Åsenlöf, 2012). Enligt Charter of the International Society of Behavioral Medicine (ISBM) beskrivs beteendemedicin som ett tvärvetenskapligt område med fokus på tillämpning av psykosocial, beteendemässig och biomedicinsk kunskap i syfte att bedöma, behandla och förebygga ohälsa (Dekker et al., 2017). Sandborgh et al. (2018) skriver att fysioterapeuter med beteendemedicinsk inriktning undersöker de beteenden som orsakar patientens besvär kopplat till funktion och rörelse, vilket utvecklar den traditionella biomedicinska och patofysiologiska undersökningen.

Samspelet mellan kognitioner, fysiologiska reaktioner, emotionella tillstånd och beteenden, i relation till individens omgivning, är centralt inom beteendemedicin (Denison & Åsenlöf, 2012). Detta perspektiv är särskilt relevant vid PPD, där tillståndet påverkas av samspelet mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Fysioterapeutiska interventioner kan adressera flera av dessa faktorer. Att tillämpa beteendemedicinskt synsätt vid behandling av depression möjliggör en mer individanpassad behandling, vilket kan bidra till minskade depressiva symtom. Samt stärka patientens copingstrategier och främja återhämtning vid komplexa psykiska tillstånd som PPD (Goldberg et al., 2003).

1.4 Socialkognitiva teorin kopplat till PPD

PPD påverkas av biologiska faktorer såsom trötthet och hormonella förändringar som samspelar med de psykologiska faktorerna såsom nedstämdhet och oro. Även omgivningsfaktorer där socialt stöd kan påverka PPD (Stewart & Vigod, 2019). För att få en bättre förståelse för hur dessa faktorer samspelar och ger upphov till de beteenden som karakteriseras av PPD kan den socialkognitiva teorin (SCT) tillämpas som teoretiskt ramverk. Den socialkognitiva teorin (SCT) beskriver hur individen, beteendet och omgivningen ständigt samverkar och påverkar varandra (Bandura, 1986). Denna teori lämpar sig därför väl för PPD då kvinnans tankar, känslor och biologiska förändringar samverkar med omgivningen och kan påverka tillståndet. En persons beteende formas av föreställningar, förväntningar och upplevda konsekvenser av ett särskilt beteende (Denison & Åsenlöf, 2012). Samspelet mellan dessa faktorer benämns som reciprocal determinism, vilket innebär att en individs tankar, känslor och biologiska faktorer har en inverkan på beteendet medan

beteendet påverkas av individens miljö och vice versa (Bandura, 1986). SCT utvecklades av Albert Bandura på 1970-talet och var en utveckling av den sociala inlärningsteorin (Bandura, 1986).

Inom SCT är self-efficacy ett centralt begrepp, vilket avser individens tilltro till sin egen förmåga att utföra ett beteende i en specifik situation. Tron på den egna förmågan har en avgörande betydelse för människans självreglering. Den påverkar vilka mål som sätts, uthålligheten vid motgångar, hur tankemönster kan hindra eller främja beteendet samt graden av sårbarhet för exempelvis depression (Bandura, 1986). Ahmadinezhad et al. (2024) menar att det finns en tydlig koppling mellan PPD och låg self-efficacy. Sambandet kan förklaras genom bland annat ett lägre självförtroende, hormonella förändringar och svårigheter i omsorgen om barnet vid PPD. Forskning visar också att self-efficacy är lägre ju mer uttalade de depressiva symtomen är (Ahmadinezhad et al., 2024).

Självkänsla definieras inom SCT som övertygelse av förmågan att påverka sitt liv och ses som en individfaktor. Genom att tro på sin förmåga att kunna påverka omständigheterna kan handlingar motiveras och avgöra ansträngningen samt uthålligheten. Det finns en stark koppling mellan självkänsla och depression. Kopplingen är starkare hos kvinnor än män och låg självkänsla visade sig öka depressiva symtomen (Szota et al., 2024).

Även socialt stöd är en viktig faktor för att upprätthålla beteenden, inom SCT är socialt stöd en omgivningsfaktor som påverkar motivation och self-efficacy (Bandura, 1986). Socialt stöd definieras som ett utbyte av resurser mellan människor, där utbytet har som syfte att förbättra mottagarnas livssituation. Det sociala stödet kan innefatta både emotionellt stöd och praktiskt stöd. Socialt stöd kan ges genom individens sociala nätverk, vilket kan inkludera individens familj, vänner eller andra betydande personer i omgivningen. Det sociala stödet har visat sig vara en viktig del för att stötta kvinnor att hantera PPD. Kvinnor med lågt socialt stöd hade högre risk att utveckla PPD och socialt stöd kan ses som en skyddsfaktor mot PPD. Socialt stöd kan även minska depressiva symtom hos kvinnor med PPD (Cho et al., 2022).

Det sker en rad olika biologiska förändringar efter förlossningen såsom trötthet och hormonella förändringar som kan samspela med de psykologiska faktorerna såsom nedstämdhet, oro och minskad self-efficacy (Stewart & Vigod, 2019). Omgivningsfaktorer påverkar även kvinnan efter förlossning där socialt stöd är en viktig faktor. Samspelet mellan individfaktorerna och omgivningsfaktorerna ger upphov till de beteenden som karakteriseras av PPD, vilket innebär låg self-efficacy, undvikandebeteende, minskad aktivitetsnivå och brister i omsorg av barnet (Cho et al., 2022). Detta förtydligar vikten av att fysioterapeuter tillämpar ett helhetsperspektiv som ser till biologiska och psykosociala faktorer vid PPD (Goldberg et al., 2003), samt uppmärksammar det kunskapsglapp som föreligger avseende interventioner för denna patientgrupp.

1.5 Problemformulering

Postpartum depression kan få biopsykosociala konsekvenser för modern men även barnet samt nära anhöriga och anses därför vara ett folkhälsoproblem. Fysioterapeuters kunskap om fysisk aktivitet är viktig vid behandling av psykiska besvär, eftersom fysisk aktivitet har positiva effekter på moderns välbefinnande. Ett beteendemedicinskt synsätt, baserat på en biopsykosocial modell, kan ge ett helhetsperspektiv som inkluderar kropp, beteende och livssituation.

Befintlig forskning fokuserar främst på medicinska och psykologiska behandlingar, medan fysioterapeutiska insatser är mindre utforskade. Fysisk aktivitet kan minska depressiva symtom, men de underliggande mekanismerna och de bredare effekterna på kvinnas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande är ännu inte tillräckligt utforskat. Vilken fysisk aktivitet och intensitet som lämpar sig bäst för populationen är ännu inte helt klarlagt. Det finns därför behov av att systematiskt undersöka hur fysioterapeutiska interventioner med beteendemedicinsk inriktning påverkar kvinnor med PPD ur ett biopsykosocialt perspektiv.

2 SYFTE

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka vilka biopsykosociala effekter fysioterapeutiska interventioner avseende fysisk aktivitet har för kvinnor med postpartum depression.

2.1 Frågeställning

- Vilka typer av interventioner har använts i studierna?
- Vilka utfall och biopsykosociala effekter har rapporterats vid fysioterapeutiska interventioner av PPD?
- Hur är interventionsuppläggen utformade vid fysioterapeutisk behandling av PPD?
- Vilka utvärderingsinstrument har använts för att mäta interventionseffekterna vid behandling av PPD och vilka psykometriska egenskaper har de använda instrumenten?
- Vilken studiekvalité uppvisar studierna enligt SBU:s mall för granskning av vetenskapliga artiklar?
- Vilken preliminär evidens uppvisar studierna enligt preliminär evidensgrad?

3 METOD

3.1 Design

Studiedesignen som valdes var en systematisk litteraturstudie med syftet att undersöka vilka biopsykosociala effekter fysioterapeutiska interventioner hade för kvinnor med postpartum depression. En litteraturstudie innebär en sammanställning av forskning som redan finns inom ett visst område, vilket kan påvisa kunskapsluckor inom forskning eller ge en övergripande bild av evidensläget som kan tillämpas kliniskt (Baker, 2016). I denna litteraturstudie inkluderades randomiserade kontrollerade studier (RCT), då denna studiedesign tenderar att ha högt evidensvärde (SBU, 2024a).

3.2 Urval

Vid genomförandet av litteraturstudien var det avgörande att formulera effektiva sökstrategier som kunde avgränsa men samtidigt inkludera alla relevanta publicerade studier. Därefter gjordes systematiska sökningar i flera databaser för att finna lämpliga studier. Två databaser användes för att kunna täcka in större ämnesområden och för att säkerställa att inga relevanta studier exkluderades, men även för att stärka kvaliteten på litteraturstudien (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, 2025).

Databaserna som användes i denna litteraturstudie var PubMed och CINAHL. PubMed är en omfattande medicinsk databas som innehåller vetenskapliga tidskrifter inom medicin, omvårdnad och odontologi. Databasen CINAHL innehåller vetenskapliga tidskrifter inom fysioterapi, arbetsterapi och medicin. Samtliga sökningar som gjordes i databaserna redovisades i en tabell med databas, filter, antal träffar, antal relevanta studier samt studiens namn (se tabell 1) (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, 2023).

I denna litteraturstudie har randomiserade kontrollerade studier (RCT) inkluderats där fysioterapeutiska interventioner undersökts för kvinnor med PPD. Studier som kombinerade fysioterapeutiska interventioner med andra interventioner exkluderades, detta för att minska risken för förväxlingsfaktorer (confounding). Förväxlingsfaktorer är faktorer som kan påverka utfallet men som inte är det direkta sambandet med det som undersöks (Jager et al., 2008).

3.2.1 Inklusionskriterier

- Studier som var publicerade mellan 2005 och 2025
- Studier som var publicerade på engelska
- Etiskt prövade och godkända studier
- Utfallsmåttet ska antingen avse biologiska, psykologiska eller sociala faktorer

- Randomiserande kontrollerade studier (RCT) som mätte effekten av fysioterapeutiska interventioner på kvinnor med PPD

3.2.2 Exklusionskriterier

- Exkludering av alla studier som inte var randomiserade kontrollerade studier (RCT)
- Exkludering av studier som innehöll fler än en fysioterapeutisk intervention

3.3 Litteratursökning

Under examensarbetets första veckor (oktober 2025) genomfördes sökningar i PubMed och CINAHL för att kontrollera att inga liknande studier fanns inom det valda området. Mälardalens universitetsbibliotek kontaktades för att få stöd i att skapa testsökningar samt undersöka behovet av justeringar i sökningarna. Syftet med testsökningarna var att undersöka forskningsläget och identifiera relevanta nyckelbegrepp. Testsökningarna gav även en ökad förståelse av databasernas uppbyggnad och en uppskattning av antal träffar och potentiella studier.

I början av november 2025 gjordes huvudsökningarna i PubMed där sökningarna filtrerades med publiceringsår (2005–2025), enbart RCT-studier och studier på engelska (se tabell 1). I sökningarna användes AND, OR och NOT för att begränsa antalet irrelevanta träffar och ökade antalet relevanta träffar. Dessa termer kallas booleska operatorer och sökningar som inkluderar termerna var programmerade att ge databasen specifika instruktioner. Operatorn AND genererar träffar med minst ett sökord i varje block medan OR väljer mellan flera olika inkluderade söktermer och NOT användes för att exkludera termer i sökningen. För att söka på exakta fraser användes citattecken (“”) och trunkering (*) användes för att inkludera olika böjningsformer (SBU, 2024a).

Det gjordes flera sökningar för att undersöka valet av sökord och för att finna adekvata sökstrategier. Inledningsvis genomfördes bredare testsökningar som inkluderade olika termer för fysioterapeutiska interventioner. Det återfanns däremot inga relevanta studier från dessa sökningar. Sökstrategin justerades därför och inriktades mot interventioner med fysisk aktivitet. Totalt inkluderades fyra olika sökningar inriktade mot fysisk aktivitet i PubMed, de tre första sökningarna var mindre och inte lika breda vilket gav färre träffar. Därför kontaktades bibliotekarien igen för att få hjälp att göra en fjärde större sökning med fler MeSH-termer för att säkerställa att inga relevanta studier missats. Den större sökningen resulterade i totalt 227 träffar. Bland dessa återfanns både redan inkluderade studier samt nio ytterligare potentiellt relevanta studier. Efter granskning visade det sig att ingen av dessa studier matchade inklusions-eller exklusionskriterierna och därför inkluderades inga nya studier från denna sökning. Sökningarna i PubMed kompletterades med en sökning i CINAHL där filter för RCT, publiceringsår (2005–2025) och tillgång till full text tillämpades.

I sökningarna kombinerades både fritextord och indexeringsord (MeSH-termer) för att få en bred sökning. Exempel på fritextord som användes var “postpartum depression” och “exercise”. I PubMed-sökningarna användes dessutom en automatisk inkludering av MeSH-termer från fritextorden, vilket innebar att databasen själv översatte fritextorden till indexeringsord. Detta resulterade i breda sökningar som inkluderade studier med liknande innehåll, vilket minskade risken för att relevanta studier missades (se bilaga C).

Tabell 1: Sökord och antal träffar i databaserna

Databas:	**Sökning:**	**Filter:**	**Antal träffar:**	**Relevanta:**	**Exkluderade efter granskning:**	**Dubbletter:**	**Inkluderade**:
PubMed	("postpartum depression" OR "postnatal depression" OR "Postpartum dysphoria") AND (exercise* OR physical activity* OR yoga OR training) AND (intervention OR therapy OR program OR trial) NOT (prevention OR perinatal)	2005-2025 RCT Engelska	100	10	7		3
PubMed	(postpartum depression[Title]) AND (exercise OR training)	2005-2025 RCT Engelska Full text	49	1			1
PubMed	("postpartum depression" OR "postnatal depression") AND ("exercise" OR "physical activity" OR "yoga" OR "training") AND ("intervention" OR "therapy" OR "program" OR "trial") NOT	2005-2025 RCT Engelska Full text	46	8	7		1

	(prevention OR perinatal)						
Pub Med	("postpartum depression" OR "postnatal depression" OR "Postpartum dysphoria") AND (exercise* OR physical activity* OR yoga OR training) AND (intervention OR therapy OR program OR trial)	2005-2025 RCT Engelska	227	9	9		0
CINAHL	postpartum depression* AND exercise*	2005-2025 RCT Engelska Full text	40	4	1	2	1

3.3.1 PICO

PICO är ett ramverk som hjälper till att dela upp forskningsfrågan i olika delar. Detta gör att sökningen i databaser blir mer strukturerad. PICO står för population, intervention, comparison/jämförelse och outcome/utfall (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, 2025). PICO-ramverket användes för att strukturera sökningar i både PubMed och CINAHL. Populationen (P) för denna litteraturstudie var kvinnor med PPD och interventionerna (I) var fysioterapeutiska insatser. I de inkluderande studierna bestod däremot interventionerna huvudsakligen av olika former av fysisk aktivitet, vilket inte var ett specifikt inklusionskriterium utan ett resultat av brist på övriga fysioterapeutiska insatser. Eftersom denna litteraturstudie inte jämförde olika interventioner utan snarare undersökte effekten av en intervention exkluderades comparison (C). Även outcome (O) exkluderades då syftet för denna studie inte var att undersöka ett visst typ av utfall.

3.3.2 Relevansbedömning

Efter sökningarna gjordes en relevansbedömning där alla studietitlar lästes av båda författarna oberoende av varandra för att sedan gemensamt granska om samsyn kring relevanta studier fanns, varpå flera irrelevanta studier exkluderades. För de studierna med relevanta titlar lästes abstrakt igenom för att undersöka om de svarade på litteraturstudiens

syfte och forskningsfrågor. Därefter gjordes en gemensam granskning av de identifierade studierna som båda författarna bedömde som relevanta för studiens syfte. Det rådde samsyn mellan författarna om urvalet av inkluderade studier för vidare granskning. Studierna som ansågs vara relevanta bedömdes av båda författarna utifrån SBU:s mall för relevansbedömning (se bilaga A). Studierna med relevans för denna litteraturstudie granskades utifrån huruvida de undersökte fysioterapeutiska interventioner, inkluderade kvinnor med postpartum depression och följde exklusions- och inklusionskriterierna. Genom en strukturerad och omfattande sökstrategi inkluderades alla relevanta studier. Totalt inkluderades sex studier, då inga ytterligare studier som uppfyllde inklusionskriterierna identifierades. Detta bedömdes även som tillräckligt för ett examensarbete på kandidatnivå.

3.3.3 Dataextraktion

Information som extraherades från varje studie redovisades i en tabell (se tabell 2), dessa delar har extraherats från samtliga studier:

- Information om studien: Titel, författare, publiceringsår och design
- Beskrivning av urval och population
- Interventionens utförande och dosering
- Primära och sekundära utfallsmått och utvärderingsinstrument
- Studiens risk för bias utifrån kvalitetsgranskning

3.4 Kvalitetsgranskning

Eftersom denna litteraturstudie inkluderade RCT-studier användes mallen RoB2 från SBU (se bilaga B). Enligt mallen kan studien ha låg, måttlig eller hög risk för bias (SBU, 2024b). Båda författarna läste igenom studierna oberoende av varandra och utgick från granskningsmallen för att bedöma kvaliteten på studierna. Därefter jämfördes och diskuterades resultaten för att stärka trovärdigheten och samsynen på granskningen. Studierna bedömdes utifrån ett flertal domäner i RoB2 och omfattade randomiseringen, avvikelser från planerad intervention, bortfall, mätning av utfallet och rapportering av resultat. Vidare bedömdes även risker för systematiska fel utifrån domänerna confounding, selektionsbias och klassificeringsbias. För varje domän uppges graden av risk för bias genom svarsalternativen ja, troligen ja, nej, troligen nej eller oklart om information saknas. Om en domän bedömdes ha hög risk för bias blev den totala bedömningen hög risk för bias. För att en studie skulle bedömas ha låg risk för bias krävdes det att samtliga domäner bedömdes ha låg risk för bias. Studierna bedömdes ha måttlig risk för bias när en domän hade måttlig risk, medan övriga domäner bedömdes ha låg risk för bias. Båda författarna var eniga om kvalitetsbedömningarna på de sex inkluderade studierna, vilket gjorde att ingen tredje part behövde granska studierna. (SBU, 2020; SBU, 2024b).

3.4.1 Utvärderingsinstrument

För att identifiera vilka utvärderingsinstrument som användes för att mäta interventionseffekter granskades metod- och resultatdelarna i de inkluderade studierna. Därefter identifierades dessa som primära eller sekundära utvärderingsinstrument och redovisades i tabell 2. För att undersöka de psykometriska egenskaperna, såsom reliabilitet och validitet användes tidigare publicerande valideringsstudier som undersökte utvärderingsinstrumenten.

3.5 Preliminär evidensgradering

För att bedöma tillförlitligheten i resultaten genomfördes en preliminär evidensgradering. I forskning som är kvantitativ används ofta den internationella mallen GRADE-systemet för att bestämma tillförlitlighet och delas in i olika evidensnivåer: hög tillförlitlighet, måttlig tillförlitlighet, låg tillförlitlighet och mycket låg tillförlitlighet (SBU, 2022b).
Denna litteraturstudie använde däremot inte GRADE då det främst är avsett för systematiska översikter och inte ett krav för denna litteraturstudie på kandidatnivå. Istället genomfördes preliminär evidensgradering som är inspirerad av GRADE. Bedömningen baserades på antalet inkluderade studier, studiernas metodologiska kvalitet utifrån risk för bias samt graden av samstämmighet mellan studiernas resultat (SBU, 2022b). Dessa faktorer vägdes samman för att göra en övergripande bedömning av preliminära evidensstyrkan.

3.6 Etik

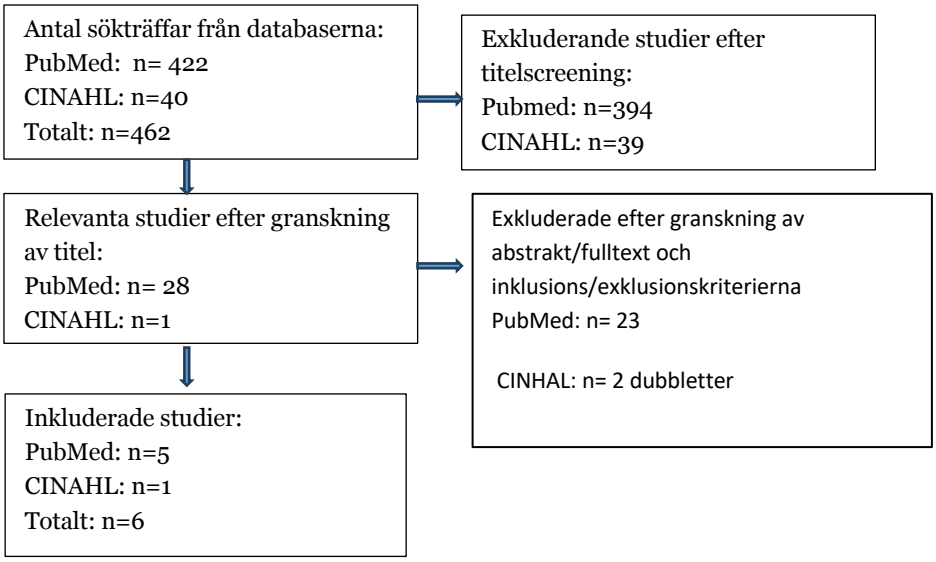
Världsläkarförbundets (WMA) mest omtalade etikpolicydokument är Helsingforsdeklarationen som säkerställer skydd och trygghet för människor som deltar i forskning (World Medical Association, 2013). Eftersom detta var en litteraturstudie som inkluderande befintlig forskning krävdes ingen etisk prövning eller godkännande. Däremot har samtliga studier som inkluderades i denna systematiska litteraturöversikt genomgått en etisk prövning och blivit godkända. Detta för att säkerställa att deltagarna i studierna har behandlats med autonomi och värdighet.

När forskning bedrivs finns krav på att följa fyra olika etiska principer, dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i studierna har fått en beskrivning av studiens syfte och upplägg, frivillighet till deltagande i studien samt eventuella risker med deltagande i studien. Samtyckeskravet handlar om att deltagande i studierna var frivilligt, och baserat på ett informerat samtycke. Samt att man när som helst har rätt till att avbryta deltagandet, vilket inte innebar några konsekvenser för de avhoppande. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska skyddas och lagras genom säker hantering och presentation av data så att enskilda individer inte kan identifieras av utomstående obehöriga personer. Slutligen innebär nyttjandekravet att insamlad data från deltagarna i forskningsprojektet endast får användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).

4 RESULTAT

4.1 Urvalsprocessen

Litteratursökningen genomfördes i PubMed och CINAHL. Efter granskning av titlar och abstrakt exkluderades studier som inte motsvarande litteraturstudiens syfte och inklusionskriterier. Därefter granskades kvarvarande studier mer detaljerat och fulltext lästes vid behov. Från PubMed identifierades fem studier och en via CINAHL, vilket blev totalt sex studier som uppfyllde inklusionskriterierna. Urvalsprocessen illustreras i figur 1, som visar flödesschemat över de inkluderade studierna.



Figur 1: Flödesschema över urvalsprocessen.

4.2 Sammanfattning av inkluderade studier

I denna systematiska litteraturöversikt inkluderades totalt sex studier. Fem av dessa studier var randomiserade kontrollerade studier och en studie var en randomiserad kontrollerad pilotstudie. Studierna var publicerade mellan åren 2008 och 2020. Studierna genomfördes i följande länder: en i USA, en i Turkiet, två i Storbritannien och två i Kanada.

Totalt deltog 373 postpartumkvinnor, av dessa deltagare utförde 191 kvinnor någon form av intervention. De olika interventionerna varade från 4 – 12 veckor, och bestod av fysisk aktivitet främst i form av aerob träning på måttlig intensitet. Återkommande typ av träning var hemmaträning, gruppträning, barnvagnspromenader och yoga. Resterande deltagare var fördelade i kontrollgrupper som fick sedvanlig vård. Urvalet bestod av kvinnor 4–52 veckor postpartum som uppvisade depressiva symtom. Depressionssymtom var det primära

utfallsmått som förekom mest frekvent och mättes främst med Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) där poängen skulle motsvara 10 eller högre, samt HAMD med en poäng på 12 eller högre för att inkluderas i studierna. Ett antal andra utfallsmått förekom också för att bland annat utvärdera fatigue, livskvalitet och self-efficacy. Kvinnorna hade inga medicinska hinder för att delta i träning och deltog inte sedan tidigare i regelbunden träning.

4.3 Beskrivning av inkluderade studier

Tabell 2 är en sammanställning av extraherad data från de sex inkluderade RCT- studierna. Tabellen redovisar studiernas författare, publiceringsår och studiedesign samt information om antal deltager och population i interventions-och kontrollgrupp. Vidare beskrivs interventioners upplägg, intensitet, frekvens och duration. Även studiernas primära och sekundära utvärderingsinstrument redovisas i den fjärde kolumnen. Därefter presenteras information om vilka utfall, biopsykosociala effekter samt studiernas signifikantvärden gällande depressiva symtom. Till sist redovisas bedömningen av risk för bias enligt SBU:s mall.

Tabell 2: Sammanställning av extraherad data för inkluderade studier.

Författare, publiceringsår, design	**Population, antal deltagare**	**Intervention och doserad träning**	**Primära och sekundära utvärderingsinstrument**	**Utfall och effekter av fysioterapeutiska interventioner:**	**Risk för bias enligt SBU**
Buttner et al. (2015). RCT.	Kvinnor mellan 18 och 45 år som fött barn inom de senaste 12 månaderna. ≥ 12 poäng på HDRS. ≥ 6 veckor efter förlossningen om förlossningen var komplicerad och/eller involverade kejsarsnitt. n: 57 n interventionsgrupp: 28 n kontrollgrupp: 29	I: Interventionen använde ett 8 veckor långt yogaprogram som bestod av 16 yogaklasser som var 1 timme långa. Deltagarna ombads även att minst 1 gång i veckan utföra ett 30 minuters långt yogapass hemma. K: Kontrollgruppen ombads att inte utöva yoga eller påbörja annan behandling under interventionsperioden.	Primära: HAMD och Inventory of depression and anxiety symptoms (IDAS) Sekundärt: Short Form Health Survey (SF-36)	Signifikanta skillnader i depressiva symtom i jämförelse med kontrollgruppen p: <0,005	Måttlig
Da Costa et al. (2009). RCT.	Kvinnor i postpartumperioden v. 4-38 som fick 10	I: Alla deltagarna fick ett individualiserat	Primära: EPDS och HAMD	Signifikanta skillnader i depressiva symtom i	Måttlig

	poäng eller högre på EPDS inkluderades. Deltagarna kunde förstå engelska eller franska, hade inget pågående substansmissbruk, deltog inte regelbundet i träning (3 x 30 min/vecka) och hade inga obstetriska eller andra sjukdomar som kunde hindra deltagande. n: 88 n interventionsgrupp: 46 n kontrollgrupp: 42	träningsupplägg som ökades gradvis och som följde ACSM:s riktlinjer. 60–120 minuters aerob träning per vecka inom 60-85% av maxpuls. Deltagarna fick även individanpassad styrketräning och stretching utifrån behov. Interventionen varade i 12 v. K: Kontrollgruppen fick sedvanlig vård.		jämförelse med kontrollgruppen $p < 0{,}001$ för de med högre EPDS-poäng $p = 0{,}02$ för de med lägre EPDS-poäng	
Daley et al. (2008). RCT pilotstudie.	Kvinnor i åldern 16 år eller äldre som upplevde depression, och vars yngsta barn var yngre än 12 månader gammalt. 12 poäng eller över på EPDS. n: 38 n interventionsgrupp: 20 n kontrollgrupp: 18	I: Interventionens huvudsakliga träningsform var att gå barnvagnspromenader. Målet var att kvinnorna skulle gå 30 minuter per dag på måttlig intensitet fem gånger i veckan, under 12 v. K: Kontrollgruppen ombads att inte ändra något i sin aktivitetsnivå. Efter interventionsperioden var över erbjöds deltagarna i kontrollgruppen en träningnskonsultation.	Primära: Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ) Sekundär: Exercise Self-efficacy scale, EPDS	Ingen signifikant skillnad i depressiva symtom mellan grupperna p:> 0.05	Hög
Dritsa et al. (2008). RCT.	Kvinnor i postpartumperioden 4–38 veckor. 10 eller mer poäng på EPDS. Inga obstetriska	I: 12 veckors individuell hemmaträning. 60–120 minuters aerob träning i veckan inom 60–85% av	Primära: Multidimensional fatigue inventory (MFI-20) Sekundära: EPDS-poäng	Ingen signifikant skillnad i depressiva symtom mellan grupperna	Hög

	komplikationer eller samtidiga sjukdomar. Deltog inte för närvarande i måttlig intensiv träning mer än 3 x 30 min per v. n: 88 n interventionsgrupp: 46 n kontrollgrupp: 42	maxpuls med individuellt anpassad träning. K: Kontrollgruppen deltog inte i någon träningsintervention utan fyllde i ett frågeformulär om fysisk aktivitet 1 gång i månaden.			
Forsyth et al. (2017). RCT.	Kvinnor som vid 6-veckorskontroll efter förlossning fick 12 eller över på EPDS och som gav skriftlig informerat samtycke inkluderades i studien. n: 22 n interventionsgrupp: 11 n kontrollgrupp: 11	I: Deltagarna skulle uppnå 150 minuters måttlig intensiv träning per vecka under 12 veckor. Träningen bestod av gruppass i form av barnvagnspromenader eller gruppträning till musik alternativt egeninitierad hemträning. Gruppträningspassen varade i 60 minuter med en intensitet på 40–65% av VO2Max. K: Kontrollgruppen uppmanades att fortsätt med sitt vanliga hälsovårdsprogram.	Primära utfallsmått: kliniska intervjuer (SCID-PN-diagnos) och EPDS-poäng	Ingen signifikant skillnad i depressiva symtom mellan grupperna Uppföljning tre månader (SCID-PN $p = 0,37$ och EPDS $p = 0,59$) Uppföljning sex månader (SCID-PN $p = 0,66$ och EPDS $p = 0,173$)	Hög
Özkan et al. (2020). RCT.	13 eller högre på EPDS. Vara mellan 20 och 35 år. Spontan vaginal förlossning mellan 38:e och 42:a graviditetsveckan. Friskt nyfött barn som vägde 2500 g eller mer. n: 80	I: Träningen skulle genomföras hemma 30 minuter per dag minst 5 gånger i veckan. De första två veckorna skulle träningen göras med lätta till medelsvåra övningar, de nästkommande två veckorna skulle övningarna vara medelsvår till svåra enligt ACOG:s	Primära: EPDS	Signifikanta skillnader i depressiva symtom i jämförelse med kontrollgruppen $P < .001$	Hög

	n interventionsgrupp: 40 n kontrollgrupp: 40	rekommendationer, interventionen varade i 4 v. K: Kontrollgruppen fick sedvanlig vård.			

I: intervention, K: kontrollgrupp, n: number.

4.4 Studiernas interventionsinnehåll

Interventionerna i de inkluderade studierna bestod huvudsakligen av aerob träning på måttlig intensitet. Träningen varierade i form och bestod bland annat av barnvagnspromenader, yoga och inslag av styrketräning. Interventionslängden varade från fyra till tolv veckor, där tolv veckor var vanligast. Träningen skedde främst i hemmet och hade planerats av utbildade inom området, ofta var det träningsfysiologer.

4.4.1 Buttner et al. (2015)

Buttner et al. (2015) genomförde en RCT-studie i USA. Interventionen använde ett åtta veckor långt yogaprogram som bestod av 16 yogaklasser som var 1 timme långa, baserat på ”Gentele Vinyasa Flow” som leddes av en utbildad yogainstruktör. De olika positioner som användes i yogaklasserna var övningar som tidigare använts i yogabaserade interventioner för depression. Deltagarna fick också med sig en DVD hem, där de uppmanades att minst en gång i veckan utföra ett yogapass hemma som var 30 minuter långt. Hemträningen följdes upp med frågor om hur ofta deltagarna tränat. Kontrollgruppen ombads att inte utöva yoga eller påbörja annan behandling under interventionsperioden.

4.4.2 Da Costa et al. (2009)

I en RCT-studie utförd av Da Costa et al. (2009) i Kanada genomfördes en 12 veckors lång träningsintervention. Alla deltagare gjorde ett läkarövervakat graderat maximalt arbetsbelastningstest med hjälp av Bruce-protokollet, därefter randomiserades deltagarna. Deltagarna i interventionsgruppen hade ett inledande möte med träningsfysiologen där resultat på arbetstestet analyserades och genomgång av träningens hälsoeffekter framfördes samt ett träningsupplägg följt av ett övervakat träningspass genomfördes. Alla deltagarna fick ett individualiserat träningsupplägg som ökades gradvis och som följde American College of Sports Medicine (ACSM:s) riktlinjer för att förbättra och bibehålla kondition. Vilket innebar 60–120 minuters aerob träning per vecka inom 60-85% av maxpuls. Deltagarna fick även styrketräning och stretching utifrån individuella behov. Uppföljning med träningsfysiologen skedde vid vecka ett, tre och nio där deltagarna fick stöd, feedback och justering av träningsintensitet. Deltagarna fick en pulsmätare och förde träningslogg. Kontrollgruppen fick sedvanlig vård som ej hade preciserats.

4.4.3 Daley et al. (2008)

I en randomiserad kontrollerad pilotstudie av Daley et al. (2008) som genomfördes i Storbritannien utfördes en 12 veckors lång träningsintervention. Interventionens huvudsakliga träningsform var att gå barnvagnspromenader. Målet var att kvinnorna skulle gå 30 minuter per dag på måttlig intensitet fem gånger i veckan. Innan interventionen påbörjades fick deltagarna en timmes lång konsultation för att komma igång med träningen, identifiera hinder, sätta mål och öka motivationen. En andra konsultation hölls en månad senare där fokus låg på att förebygga återfall till ett stillasittande beteende. Deltagarna fick även vecka tre och nio korta stödsamtal för att följa upp och få hjälp att hantera eventuella svårigheter som hindrade en beteendeförändring. Kontrollgruppen ombads att inte ändra något i sin aktivitetsnivå. Efter interventionsperioden var över erbjöds deltagarna i kontrollgruppen en träningskonsultation.

4.4.4 Dritsa et al. (2008)

Dritsa et al. (2008) genomförde en RCT-studie i Kanada. I studien genomfördes 12 veckors individuell hemmaträning som intervention, under ledning av en träningsfysiolog som deltagarna i interventionsgruppen träffade vid fyra tillfällen. Första mötet skedde vid baslinjen där deltagarna fick information om träningsfördelar, säkerhetsaspekter och träningsupplägg. Uppföljning skedde individuellt första, tredje och nionde veckan under interventionsperioden. Under dessa möten fick kvinnorna stöd, motivation och gradvis ökning av träningsintensitet. Interventionen bestod av 60–120 minuters aerob träning i veckan inom 60–85% av maxpuls med individuellt anpassad träning och följde riktlinjerna från ACSM för att bibehålla kardiorespiratorisk kondition. Deltagarna tilldelades en pulsmätare och förde träningslogg som skickades in varje månad. Följsamheten beräknades som andelen utförda pass jämfört med planerade. Kontrollgruppen deltog inte i någon träningsintervention utan fyllde i ett frågeformulär om fysisk aktivitet en gång i månaden.

4.4.5 Forsyth et al. (2017)

Forsyth et al. (2017) genomförde en RCT-studie i Storbritannien. Målet med studiens intervention var att deltagarna skulle uppnå 150 minuters måttlig intensiv träning per vecka under 12 veckor. Träningen kunde genomföras på olika sätt beroende på vad deltagarna föredrog. Man kunde välja mellan strukturerade gruppass och egeninitierad hemträning. Gruppträningen som erbjöds var barnvagnspromenader eller gruppträning till musik med gratis barnomsorg. Gruppträningspassen varade i 60 minuter med en intensitet på 40–65% av VO2Max. Innan interventionen startade fick träningsgruppen en initial konsultation baserad på beteendeförändringstekniker för att motivera deltagarna till träning. Deltagarna som hamnade i kontrollgruppen uppmanades att fortsätta med sitt vanliga hälsovårdsprogram.

4.4.6 Özkan et al. (2020)

I en RCT-studie som genomfördes i Turkiet av Özkan et al. (2020) tilldelades interventionsgruppen ett träningsprogram på fyra veckor. Träningen skulle genomföras hemma 30 minuter per dag minst fem gånger i veckan. De första två veckorna skulle träningen göras med lätta till medelsvåra övningar, de nästkommande två veckorna skulle övningarna vara medelsvår till svåra enligt American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) rekommendationer. Kvinnorna fick ett häfte med övningarna. De skulle dagligen anteckna hur länge, när och på vilken nivå de tränade på. En uppföljning skedde varje vecka på telefon. Träningen var baserad på tidigare forskning och hade tagits fram i samråd med tre experter inom postpartumträning. Deltagarna fick information om fördelar med träning och hur interventionen skulle gå till. Det första träningspasset genomfördes i grupp på vårdcentral. Kontrollgruppen fick information om standardvårdpraxis och fick efter att studien var avslutad tillgång till träningsprogrammet.

4.5 Utvärderingsinstrument och utfallsmått

I följande avsnitt presenteras de primära och sekundära utvärderingsinstrument och dess utfallsmått för de sex inkluderande studierna, samt en redogörelse för instrumentens psykometriska egenskaper. För att mäta depressiva symtom användes främst Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) som visar på goda psykometriska egenskaper, men även andra självskattningsinstrument har förekommit.

4.5.1 Primära utvärderingsinstrument och utfallsmått

RCT-studierna i denna litteraturstudie använde flera olika utvärderingsinstrument och utfallsmått (se tabell 2). Samtliga inkluderade studier med undantag för Buttner et al. (2015) använde Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) som primärt eller sekundärt utfallsinstrument. EPDS är ett självskattningsformulär som uppvisar god sensitivitet och specificitet för att identifiera symtom på PPD hos kvinnor (Park & Kim, 2023).

Hamilton Depression Rating Scale (HAMD eller HAM-D) har använts i studierna Buttner et al. (2015) och Da Costa et al. (2009) som primärt utfallsinstrument för att mäta depression. Enligt Gerbasi et al. (2020) är HAMD ett “gold standard-mått”, vilket innebär att det ofta används som referens vid granskning av andra skattningsskalor. HAMD har även visat sig ha god stabilitet över tid, vilket tyder på en god reliabilitet. Tidigare forskning visar på goda psykometriska egenskaper för HAMD (Gerbasi et al., 2020).

Inventory of depression and anxiety symptoms (IDAS) användes av Buttner et al. (2015) som primärt utfallsinstrument och är ett självskattningsformulär för att mäta depression samt ångestsymtom. Skalorna har en god struktur och mäter de avsedda symtomen på ett

tillförlitligt sätt. Verktyget har även en god validitet och en god generaliserbarhet då testet har bekräftats på flera olika populationer däribland nyblivna mödrar (Watson et al., 2007).

Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ) användes som primärt utvärderingsinstrument i studien av Daley et al. (2008), för att bedöma den fysiska aktivitetsnivån. Instrumentet beräknar Leisure Score Index (LIS) baserat på antalet träningspass på varje intensitetsnivå multiplicerat med fasta MET-värden. GLTEQ beskrivs som ett instrument för att följa förändring över tid och rangordna individers aktivitetsnivå, med måttlig validitet jämfört med objektiva aktivitetsmått (Amireault et al., 2015).

Multidimensional fatigue inventory (MFI-20) är ett självskattningsinstrument som innehåller 20 punkter för att mäta fatigue, vilket har använts i studien Dritsa et al. (2008) som primärt utfallsinstrument. Instrumentet utvärderar fysisk och mental trötthet samt aktivitet och motivation. MFI-20 uppvisar god reliabilitet, vilket möjliggör en konsekvent och stabil mätning av fatigue. Instrumentet visar på god validitet genom ett starkt samband med CR-10-skalan, vilket indikerar god tillförlitlighet (Hagelin et al., 2007).

För att identifiera psykiska symtom och dess svårighetsgrad användes strukturerade kliniska intervjuer (SCID) i studien av Forsyth et al. (2017). SCID är baserad på diagnostiska och statistiska manualen för psykiska störningar, fjärde upplagan (DSM-IV) och har visat god interbedömarreliabilitet för identifiering av egentlig depression. Den anpassade versionen SCID-PND bedöms vara tillförlitlig och användbar för att identifiera postpartum depression (Gorman et al., 2019).

4.5.2 Sekundära utvärderingsinstrument och utfallsmått

Short Form Health Survey (SF-36) användes som ett sekundärt utfallsmått i studien av Buttner et al. (2015) för att identifiera funktion och livskvalitet. Enkäten består av 36 frågor som utvärderar fysisk funktion, begränsningar för den fysiska hälsan, kroppssmärta, generell hälsa, social funktion, begränsningar för känslomässiga hälsoproblem och psykisk hälsa. Instrumentet har visat god validitet och reliabilitet och anses vara tillförlitligt för att mäta hälsorelaterad livskvalitet (Bardage et al., 2023).

Exercise self-efficacy (ESES-S) användes i studien av Daley et al. (2008) för att utvärdera self-efficacy relaterat till fysisk aktivitet. Instrumentet omfattar fyra dimensioner: tilltron till att träna trots yttre hinder, tilltron till att träna trots inre tillstånd exempelvis depression, tilltron till att klara olika intensitetsnivåer och tilltron att klara olika träningsformer. Instrumentet skattas på en procentuell skala som har visat god validitet och reliabilitet (Nessen et al., 2015).

4.6 Utfall och effekter av fysioterapeutiska interventioner på PPD

I följande avsnitt presenteras de primära effekterna av de fysioterapeutiska interventionerna i de inkluderade studierna vilket var minskade depressiva symtom ofta i större omfattning än i kontrollgrupperna. Huvudsakligt fokus var på mellangruppjämförelser i depressiva symtom, där tre av sex studier uppnådde statistiskt signifikanta resultat mellan grupperna. Även om effekterna på depressionsmått inte alltid var statistiska signifikanta mellan grupperna, sågs biopsykosociala effekter inom flera interventionsgrupper som tydde på ökat välbefinnande, livskvalitet, trötthet och ökad self-efficacy.

4.6.1 Buttner et al. (2015)

Interventionen resulterade i en signifikant större minskning av depressiva symtom i jämförelse med kontrollgruppen över tid (t = −2,94; *df* = 52; p <0,005) vilket mättes med HAMD. Ingen noterad skillnad mellan grupperna gällande paniksymtom mätt med IDAS Panic scale. En signifikant snabbare förbättring sågs även hos interventionsgruppen i mått som ångest, välbefinnande och hälsorelaterad livskvalitet i jämförelse med kontrollgruppen. 78% av kvinnorna visade på klinisk signifikant förbättring gällande depression, ångest och livskvalitet. Även hos deltagarna i kontrollgruppen noterades en minskning av depressiva symtom över tid, men förbättringen var mindre uttalad i jämförelse med interventionsgruppen. Trots det upplevde 59% av kvinnorna en kliniskt signifikant förbättring. Förbättringar gällande välbefinnande och ångest noterades inte i samma omfattning som för interventionsgruppen.

4.6.2 Da Costa et al. (2009)

Interventionsgruppen uppnådde signifikanta skillnader i depressiva symtom i jämförelse med kontrollgruppen. Det noterades att kvinnor med högre EPDS-poäng vid baslinjen (EPDS över 13 poäng) uppvisade en signifikant större förbättring efter interventionen i jämförelse med kontrollgruppen (medelskillnad på 4,06 poäng, 95 % KI: 1,51–6,61, $p < 0,001$). Deltagare med lägre EPDS-nivåer vid baslinjen (lägre än 13 poäng) visade på mindre förbättring av symtomen (2,77 poäng, 95 % KI: 0,50–5,05, $p = 0,02$). Poängen på HAMD minskade också och effekten var störst efter avslutad intervention −1,83 (−3,41, −0,24). Vid uppföljande mätning efter 6 månader var skillnaden mellan grupperna inte lika stora −0,26 (−1,78, +1,26).

I kontrollgruppen noterades också en förbättring av kvinnornas depressiva symtom över tid, men i mindre omfattning än interventionsgruppen. Efter justeringar av baslinjevärden hade kvinnor med högre EPDS-poäng vid baslinjen mer kvarstående symtom i kontrollgruppen i jämförelse med interventionsgruppen. Poängen på HAMD förbättrades likvärdigt med interventionsgruppen vid den 6 månaders uppföljande mätningen vilket indikerade på att det tar längre tid att förbättra symtomen för kontrollgruppen.

4.6.3 Daley et al. (2008)

EPDS-poängen förbättrades i båda grupperna vid uppföljning och uppnådde ingen signifikant skillnad mellan grupperna (14,3 för kontrollgruppen och 13,1 för interventionsgruppen, medelvärdesskillnad 1,2; 95% KI -5,2 till 2,8). Däremot noterades en statistiskt signifikant skillnaden mellan grupperna gällande self-efficacy för träning, som var högre för interventionsgruppen (p=0,002).

Kvinnorna i interventionsgruppen såg barnvagnspromenader som positiva och upplevde förbättringar på deras humör och allmänna hälsa. Majoriteten av deltagarna rapporterade att promenad i grupp med andra kvinnor som också upplevde symtom på PPD hade uppskattats och skulle bidra till ökad träningsnivå.

4.6.4 Dritsa et al. (2008)

Ingen signifikant skillnad i depressiva symtom mellan grupperna noterades under interventionsperioden eller vid uppföljningen. En signifikant minskning av fysisk trötthet (-4,07 poäng, 95% KI: -5,15 till -2,98, p= 0,001) sågs direkt efter interventionen. Vid uppföljningen efter 3 månader kvarstod effekten i jämförelse med kontrollgruppen (-4,24 poäng, 95% KI: -5,36 till -3,12, p= 0,025).

Sekundära utfallsmåtten så som allmän trötthet, minskad aktivitet och minskad motivation visade på signifikanta förbättringar efter avslutad intervention. Bestående effekt för minskad motivation sågs fortsatt vid uppföljningen efter 3 månader i jämförelse med kontrollgruppen. För mental trötthet noterades inga signifikanta förbättringar direkt efter avslutad interventionen mellan grupperna. Vid uppföljningen 3 månader efter avslutad intervention noterades en statistiskt signifikant förbättring främst hos de kvinnor som följde träningsprogrammet noga i jämförelse med kontrollgruppen.

4.6.5 Forsyth et al. (2017)

Ingen signifikant skillnad i depressiva symtom mellan grupperna noterades under interventionsperioden eller vid uppföljningen. Det uppvisades inga signifikanta effekter på SCID-PN-diagnoser eller depressiva symtom vid uppföljning på tre månader (SCID-PN p = 0,37 och EPDS poäng p = 0,59) eller sex månader efter avslutad intervention (SCID-PN p = 0,66 och EPDS poäng p = 0,173) i jämförelse med kontrollgruppen.

Deltagarna i interventionsgruppen upplevde träningen som positiv. Det rapporterades förbättrad mental hälsa, ökat självförtroende, motståndskraft och även sociala fördelar och ökad motivation till fortsatt träning.

4.6.6 Özkan et al. (2020)

Interventionsgruppen uppnådde signifikanta skillnader i depressiva symtom i jämförelse med kontrollgruppen $P < .001$. EPDS-poängen mellan grupperna var jämförbara innan påbörjad intervention. Interventionsgruppen hade en poäng på 16,41 ± 1,61 före

interventionen i jämförelse med kontrollgruppen som hade en poäng på 15,74 ± 2,35. Efter avslutad intervention hade EPDS-poängen minskat markant i interventionsgruppen, till 7,29 ± 1,67 i jämförelse med kontrollgruppens poäng som var 12,54 ± 2,65.

4.7 Studiekvalitet

Denna litteraturstudie inkluderade RCT-studier och därav användes mallen RoB2 från SBU för kvalitetsgranskning och bedömning av risk för bias (se bilaga B). Totalt granskades sex studier, och kvalitetsgranskningen resulterade i att fyra studier som ansågs ha hög risk för bias vilket var studierna av Daley et al. (2008), Dritsa et al. (2008), Forsyth et al. (2017), samt Özkan et al. (2020). De två resterande studierna ansågs efter kvalitetsgranskning ha måttlig risk för bias vilket var Da Costa et al. (2009) och Buttner et al. (2015). Se tabell 3 för samlad sammanställning av bedömningen av risk för bias.

Studierna av Da Costa et al. (2009) och Buttner et al. (2015) bedömdes ha en måttlig risk för bias efter kvalitetsgranskning vilket huvudsakligen grundades på låg risk inom randomiseringsprocessen, bortfall och mätning av utfall. Bristerna i studierna var kopplade till selektiv rapportering samt avvikelser avsedd interventionen.

De fyra kvarstående studierna bedömdes efter kvalitetsgranskningen ha hög risk för bias vilket var studierna av Daley et al. (2008), Dritsa et al. (2008), Forsyth et al. (2017), samt Özkan et al. (2020). Detta till följd av avvikelser från avsedd intervention, hög eller oklar bortfallsfrekvens samt variation i mätning av utfall. Även selektiv rapportering förelåg i dessa studier, samt att i två av studierna rapporterades inte intressekonflikter. Sammanfattningsvis innebar den övervägande höga risken för bias att det samlade evidensläget för interventionsresultaten var svagare och bör tolkas med försiktighet.

Tabell 3: Sammanställning av risk för bias enligt SBU:s mall för bedömning av risk för bias i RCT studier.

	Buttner et al. (2015)	**Da Costa et al. (2009)**	**Forsyth et al. (2017)**	**Dritsa et al. (2008)**	**Daley et al. (2008)**	**Özkan et al. (2020)**
1. *Randomiseringsprocess*	Låg	Låg	Låg	Låg	Måttlig	Måttlig
2. *Avvikelser från avsedd intervention*	Måttlig	Måttlig	Hög	Hög	Hög	Hög
3. *Bortfall*	Låg	Låg	Måttlig	Låg	Låg	Hög
4. *Mätning av utfall*	Låg	Låg	Låg	Måttlig	Måttlig	Låg

5. *Selektiv rapportering av resultat*	Måttlig	Måttlig	Måttlig	Måttlig	Måttlig	Måttlig
6. *Intressekonflikter*	Risk	Nej	Risk	Nej	Nej	Nej

4.8 Preliminär evidensstyrka

Eftersom detta är en litteraturstudie på kandidatnivå har ingen fullständig GRADE genomförts för att bedöma evidensstyrkan. Istället har evidensstyrkan bedömts utifrån preliminär evidensstyrka, vilket baseras på studiedesign och risk för bias. Samtliga inkluderade studier är randomiserade kontrollerande studier, vilket utgör en hög preliminär evidensstyrka baserat på dess studiedesign. Däremot sänks evidensstyrkan då studierna uppvisar hög till måttlig risk för bias. Den preliminära evidensstyrkan bedöms därför som måttlig.

5 DISKUSSION

5.1 Resultatsammanfattning

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka effekten av fysioterapeutiska interventioner på kvinnor med PPD. Totalt inkluderades sex RCT-studier mellan åren 2008–2020 där 373 kvinnor med PPD som var mellan 4–52 veckor postpartum inkluderades. Studiernas interventioner varierade men bestod främst av aerob träning såsom strukturerade barnvagnspromenader, hemträning och yoga. Interventionerna varade mellan 30–60 minuter på främst måttlig intensitet, 2-3 gånger i veckan under 4–12 veckor.

För att mäta depressiva symtom användes främst EPDS. Tre av studierna visade statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna gällande depressiva symtom, som visades genom minskade poäng på utvärderingsinstrumenten (EPDS och HAMD). I några av studierna resulterade interventionerna i ett upplevt ökat socialt stöd, minskad fysisk trötthet och ökad self-efficacy kopplat till träning inom interventionsgruppen. Resultaten pekar på att strukturerad aerob träning främst kan minska depressiva symtom, men även i vissa fall minska trötthet och öka self-efficacy vid PPD. Samtidigt som sociala inslag i kombination med fysisk aktivitet tros kunna stärka det sociala stödet.

5.2 Resultatdiskussion

I tre studier (Buttner et al. (2015), Özkan et al. (2020) och Da Costa et al. (2009) uppnådde deltagarna i interventionsgruppen statistiskt signifikanta förbättringar av depressiva symtom mätt med EPDS och HAMD i jämförelse med kontrollgruppen. För att förstå dessa resultat kan de sättas i relation till tidigare forskning, där en minskning av depressiva symtom delvis kan tolkas genom studien av Deprato et al. (2025) som visat att regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra stressreglering. Förbättrad stressreglering vid PPD är viktigt då de patofysiologiska processerna bland annat innebär hormonella förändringar som kan påverka emotionell reglering, motivation och stressrespons. Flera biologiska system påverkas av hormonella förändringar däribland HPA-axeln och immunsystemet som reglerar stress och emotionella funktioner. Genom en förbättrad stressreglering kan belastningen minska på dessa system och leda till stabilare emotionell reglering och därmed minskade depressiva symtom (Stewart & Vigod, 2019).

I studierna av Dritsa et al. (2008), Forsyth et al. (2017) och Daley et al. (2008) uppvisade inte deltagarna i interventionsgruppen statistiskt signifikanta resultat på depressionsnivån i jämförelse med kontrollgruppen. Generellt sett hade även dessa studier lägre följsamhet till interventionerna, vilket är något som också kan ha påverkat behandlingseffekten. Detta skulle kunna tyda på att följsamhet är centralt för interventionens effekt. I de studier där interventionsgruppen uppvisade statistisk signifikant förbättringar jämfört med kontrollgruppen, såsom Özkan et al. (2020) och Da Costa et al. (2009) uppvisades relativt hög följsamhet. Det var även i dessa studier de största minskningarna av depressiva symtom mellan grupperna observerades mätt med EPDS- och HAMD.

I studien av Dritsa et al. (2008) som inte uppvisade statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna rapporterades en relativt hög träningsnivå på kontrollgruppen, i genomsnitt 54,6 minuters träning per vecka i jämförelse med interventionsgruppens 124 minuter i genomsnitt per vecka. Även om detta motsvarar en skillnad på ungefär 70 minuters träning per vecka kan båda grupperna uppnått en träningsnivå som ligger inom intervallet där antidepressiva effekter kan uppnås. Detta överensstämmer till viss del med tidigare forskning och rekommenderad träningsdos av Deprato et al. (2025). Detta är något som därför kan ha påverkat resultat och orsakat att det inte blev någon signifikant skillnad i depressiva symtom mellan grupperna till följd av misstänkt kontaminering av interventionen. Träningstiden varierade i de olika interventionerna men majoriteten av studierna hade som mål att deltagarna skulle uppnå 150 minuters träning i veckan. Två av studierna Dritsa et al. (2008) och Da Costa et al. (2009) hade ett lägre mål på 60–120 minuter måttlig aerob träning per vecka. I metaanalysen av Deprato et al. (2025) kom man fram till en rekommenderad effektiv träningsdosering på minst 350 MET-min/vecka minst fyra gånger i veckan, vilket motsvarar ungefär 80 minuters träning på måttlig intensitet per vecka. Detta visar på variation i träningsdos i de inkluderande studierna, där positiva effekter på depressiva symtom även visades vid lägre träningsdoser. Samtidigt pekar Dennis et al. (2024) på att 150 minuter eller mer per vecka kan ge ytterligare symtomlindring. Den betydande variationen i träningsdos mellan olika studier, försvårar därmed tydliga slutsatser om optimal träningsmängd vid PPD.

Träningsinnehållet i de fysioterapeutiska interventionerna varierade i de sex inkluderade studierna. De träningsformer som förekom i studierna var aerob träning, kombinerade program och yoga. Vilken typ av fysisk träning som utövades tycks inte vara avgörande, utan istället verkar regelbundenhet och följsamhet vara det som kan ha störst betydelse. En fysiologisk förklaring till varför träning ger effekt på depressiva symtom kan kopplas till träningens påverkan på neuroplasticitet, där fysisk aktivitet ökar frisättningen av BDNF och serotonin, vilket förbättrar återhämtning och emotionell stabilitet vid depression (Govindaraj et al., 2016). Detta kan förklara varför olika typer av fysisk aktivitet uppnår liknande psykologisk effekt. Denna aspekt är särskilt relevant eftersom kvinnors fysiska, psykiska och sociala förutsättningar skiljer sig åt (Stewart & Vigod, 2019). Det tydliggör behovet av individanpassade insatser vid PPD som förenligt med ett biopsykosocialt och beteendemedicinskt perspektiv (Denison & Åsenlöf, 2012). Detta går i linje med studien av Da Costa et al. (2009) som genomförde en individanpassad intervention som även resulterade i statiskt signifikanta resultat mellan grupperna gällande depressiva symtom.

Detta kan förankras i SCT, där samspelet mellan beteende, individ och omgivning är centralt (Bandura, 1986). Samtliga interventioner innefattade regelbunden fysisk aktivitet och i flera studier regelbunden uppföljning. Detta kan ha påverkat self-efficacy och aktivitetsnivå, vilket beskrivs som centralt inom SCT (Bandura, 1986). PPD är kopplat till låg self-efficacy och självförtroende, vilket kan leda till undvikandebeteende och minskad aktivitetsnivå (Ahmadinezhad et al., 2024). Self-efficacy mättes i studien av Daley et al. (2008) och resulterade i statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna till fördel för interventionsgruppen. Får personer med PPD en ökad tilltro till att utföra fysisk aktivitet kan det leda till att stimulera viljan att fortsätta vara fysiskt aktiva (Ahmadinezhad et al., 2024). Förutom individfaktorers betydelse för PPD framkom även omgivningsfaktorers betydelse.

Enligt SCT är socialt stöd en avgörande omgivningsfaktor för motivation, beteende och self-efficacy (Bandura, 1986). I studierna av Forsyth et al. (2017) och Daley et al. (2008) bestod interventionerna av barnvagnspromenader. Forsyth et al. (2017) genomförde barnvagnspromenaderna och träning till musik tillsammans med andra kvinnor med PPD, vilket kan ha bidragit till upplevelsen av ökat socialt stöd och ökad motivation till fysisk aktivitet inom interventionsgruppen. Samtidigt kan ett lågt socialt stöd öka både svårighetsgraden och risken för att utveckla PPD (Cho et al., 2022). I studien av Daley et al. (2008) rapporterade majoriteten av deltagarna i interventionsgruppen att träningsnivån hade ökat om barnvagnspromenaderna skedde tillsammans med andra kvinnor med PPD. Fysisk aktivitet i kombination med social interaktion kan möjligtvis underlätta beteendeförändring och vidmakthållande av aktivitet hos kvinnor med PPD. Däremot bör tolkningen av socialt stöd göras med försiktighet då det inte var ett primärt utfallsmått i studien av Forsyth et al. (2017) eller Daley et al. (2008), utan framkom främst utifrån deltagarnas upplevelser. Detta betonar behovet av att framtida studier bör inkludera sociala utfallsmått för en djupare förståelse av effekterna.

Vidare kan även den sedvanliga vården ha påverkat resultaten i studierna. Detta då samtliga studier inte redovisade vad som ingick i den sedvanliga vården, vilket gör det svårt att avgöra hur interventions-och kontrollgrupperna faktiskt skilde sig åt. Det är också oklart hur den

sedvanliga vården definierades i olika länder och vårdkontexter, då denna nödvändigtvis inte innebär samma sak överallt. Om den sedvanliga vården exempelvis innehöll allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet kan det ha lett till att kontrollgrupperna ökade sin fysiska aktivitetsnivå och därmed påverkat resultatens statistiska signifikans. Det kan då även ha påverkat studiernas reproducerbarhet och försvårat slutsatser av resultatet.

Avseende intensiteten på interventionsuppläggen hade majoriteten av studierna en intervention med måttlig intensitet. Studierna av Da Costa et al. (2009) och Dritsa et al. (2008) hade båda en intensitet på 60–85% av maxpuls. Da Costa et al. (2009) var en av de studier som uppnådde signifikanta skillnader mellan grupperna gällande depressiva symtom och hade endast måttlig risk för bias, vilket tyder på att måttlig intensitet är tillräcklig. I studien av Forsyth et al. (2017) var intensiteten på 40–65% av VO2Max. Trots att inga signifikanta skillnader mellan grupperna uppnåddes gällande depressiva symtom upplevde kvinnorna i interventionsgruppen förbättrad mental hälsa, ökat självförtroende, motståndskraft, sociala fördelar och ökad motivation till fortsatt träning som visar på troliga kliniska relevanta effekter. Enligt Govindaraj et al. (2016) sker en ökad frisättning av tillväxtfaktorer som Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), immunförsvaret stärks och den kroniska inflammationen minskar när träningen utförs på en måttlig nivå. Träningen ger även andra positiva effekter som kan förklaras genom psykologiska och biologiska mekanismer, såsom förbättrad självkänsla, minskad stress och förbättrad coping (Deprato et al., 2025). Träningen leder även till ökade serotonin- och dopaminnivåer, minskat kortisol samt minskad inflammation (Deprato et al., 2025), vilket är betydelsefullt då nyblivna mödrar med depressiva symtom ofta kan ha begränsad energi, nedstämdhet och återhämtning (Stewart & Vigod, 2019).

Något som kan påverka generaliserbarheten och jämförbarheten av resultaten mellan studierna är bland annat skillnader i urval, inklusionskriterier och mätinstrument. Intervallet mellan de olika inklusionskriterierna är stort och varierar från sex veckor till 12 månader postpartum i de inkluderade studier. Vilket kan innebära att det finns olika grader av naturlig symtomförbättring i urvalet. Även inklusionskriterierna gällande grad av depressiva besvär skiljde studierna åt gällande poäng på olika depressiva skattningsskalor. Detta kan innebära att deltagarna har haft olika initial svårighetsgrad av depressiva symtom vilket därmed kan ha påverkat interventionens effekt, då det bland annat framkom i studien av Da Costa et al. (2009) att interventionen hade bättre effekt på de deltagare som hade en högre EPDS-poäng vid baslinjen. Vidare redovisade inte de inkluderade studierna information om komplikationer, förlossningssätt och samsjuklighet och hur det kan påverka biopsykosociala aspekter vid PPD. Detta påverkar generaliserbarheten, då de inkluderade studierna endast speglar en del av de kvinnorna med PPD och därmed inte nödvändigtvis kan generaliseras till den delen av populationen med mer komplex problematik.

Studierna hade också valt olika primära utfallsmått. De varierade från självskattningsinstrument så som EPDS, till andra kliniska bedömningar så som HAMD, SCID och IDAS. Detta är olika typer av utfallsmått som inte mäter exakt samma aspekter av depressiva symtom vilket kan påverka generaliserbarheten och jämförbarheten mellan studierna. Detta kan exempelvis ses i de inkluderade studier då Buttner et al. (2015) som

främst använde sig av det kliniska diagnostiska instrumentet HAMD som rapporterade en statistisk signifikant förbättring av depressiva symtom medan studier som enbart använde självskattning visade mer varierade resultat.

Fyra av de inkluderade studierna bedömdes ha en hög risk för bias, och de ytterligare två kvarvarande studierna (Buttner et al. 2015: Da Costa et al. 2009) bedömdes ha måttlig risk för bias. Detta sammanfaller med de två studier som också rapporterade tydliga effekter av interventionerna, vilket stärker antagandet att bättre metodologisk kvalitet kan ge mer tillförlitliga resultat. Den genomgående höga risken för bias gör det också svårare att jämföra studierna och dra korrekta slutsatser. En faktor som har påverkat att studierna har bedömts som hög risk för bias är avsaknad av blindade behandlare och studiedeltagare, detta kan innebära en risk för bedömningsbias och presentationsbias i synnerhet när utfallsmåtten är baserade på självskattningsinstrument (SBU, 2020). Däremot är blindning ofta svårt inom tränings-och fysioterapeutiska interventioner. Vidare var bristfällande rapportering av randomiseringsprocessen en återkommande orsak som ökade risken för bias, detta kan påverka risken för selektionsbias enligt SBU (2020).

Trots de begränsningar som finns gällande studiernas genomgående höga till måttliga risk för bias visar resultatet att fysioterapeutiska insatser i form av fysisk aktivitet kan vara meningsfullt och kan ha effekt för kvinnor med PPD. Fysisk aktivitet kan därför övervägas som komplement till dagens behandling som främst är farmakologisk och psykologisk (SBU, 2022a). Fysioterapeuter kan bidra med betydande kunskap vad gäller träning och beteendestöd vilket gör professionen central ur ett biopsykosocialt omhändertagande där kvinnors resurser, kontext och barriärer tas i beaktande. Detta styrks av Liu et al. (2024) som menar att fysioterapeuten har en central roll i att främja hälsa även när det gäller psykiska besvär.

5.3 Metoddiskussion

En systematisk litteraturöversikt valdes eftersom den möjliggjorde en strukturerad sammanställning av befintlig forskning inom ett visst område. Däremot hade en kvalitativ studiedesign som undersöker kvinnors erfarenheter av fysioterapeutiska interventioner vid PPD gett en djupare analys och förståelse (Graneheim et al., 2017). Kvalitativa studier ger sällan överförbara resultat vilket gör det svårt att dra slutsatser om samband (Graneheim et al., 2017). Därför lämpar sig en litteraturstudie som ger en bredare översikt av effekten. En scoping review hade kunnat vara lämplig om syftet med studien varit att kartlägga ett forskningsområde på ett bredare plan och ge en övergripande bild av befintlig forskning (Munn et al., 2018). Systematiska litteraturstudier är däremot lämpligare när forskningsfrågan är mer avgränsad och syftar till att undersöka specifika effekter, vilket även möjliggör en strukturerad sammanställning av resultat med kvalitetsgranskade studier (Munn et al., 2018). Därmed är denna design lämpligare för att besvara denna studies syfte. Vidare tänkbara studiedesigner är en RCT-studie. Fördelar med en RCT-studie är att den undersöker orsak-verkan, vilket stärker uttalanden om effekten (Zabor et al., 2020). Däremot

kräver RCT-studier mycket resurser och tid hävdar Zabor et al. (2020), vilket hade blivit utmanande för ett examensarbete på kandidatnivå. Dessutom finns det redan ett flertal RCT-studier som undersöker effekt av fysisk aktivitet vid PPD, vilket betyder att syftet skulle behöva revideras för att bli unikt. Därför anses en litteraturstudie återigen vara den mest lämpliga studiedesignen för syftet att möjliggöra slutsatser på en bredare population.

Som tidigare nämnt anses RCT-studier ha en hög evidensstyrka och undersöker effekten av en intervention, därför valde denna litteraturstudie att inkludera enbart RCT-studier. RCT-studier innebär att deltagarna i studien slumpmässigt fördelas in i interventionsgrupp och kontrollgrupp, vilket minskar risken för systematiska skillnader och därmed selektionsbias. Det leder även till en stärkt intern validitet och en tillförlitligare bedömning (SBU, 2023). Sammanfattningsvis innebär detta att resultatet blir lättare att generalisera till hela populationen som undersöktes (SBU, 2023). Däremot medför RCT-studier etiska utmaningar och risk för bortfall som kan påverka kvaliteten på studien. Därför kan andra studiedesigner anses som lämpliga att undersöka, exempelvis single-case experimental design. Denna design kan användas på mindre urval och möjliggöra en djupare information om individuella effekter över tid. Designen hade kunnat varit ett alternativ i denna studie för att belysa effekten av fysioterapeutiska interventioner på enskilda individer med PPD (Machalicek et al., 2024).

PubMed valdes då det är den största medicinska databasen och täcker biomedicinsk litteratur, vilket var relevant för studiens syfte att undersöka fysioterapeutiska interventioner (Charles Sturt University, 2025). Databasen finns tillgänglig för alla och är gratis, vilket bidrog till transparens i sökprocessen. En nackdel med PubMed är att för full åtkomst till artiklarna kräver extra behörighet, vilket inte påverkade denna studie då full åtkomst var tillgängligt för alla studier av intresse (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, 2024). CINAHL är en databas som främst innehåller studier inom fysioterapi, arbetsterapi, medicin och omvårdnad, vilket gör den relevant för studiens ämnesområde. En nackdel med CINAHL är att databasen inte är lika omfattande som PubMed, gällande antal publicerade publikationer (Lunds universitet, 2016). Genom en kombination av PubMed och CINAHL kunde sannolikheten att hitta relevanta studier öka. (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, 2024). Att enbart göra sökningar i databaser medför en ökad risk att missa relevant grå litteratur, exempelvis rapporter, avhandlingar eller kliniska riktlinjer framtagna av exempelvis universitet eller myndigheter vilket är exempel på grå litteratur. Grå litteratur kan ge kompletterande perspektiv, däremot görs inte samma noggranna kvalitetsgranskningar på grå litteratur som i vetenskapliga publikationer, vilket kan påverka tillförlitligheten (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, 2023). Därför har denna litteraturstudie valt att fokusera på peer-reviewed studier från välkända databaser för att stärka kvaliteten.

Inklusions- och exklusionskriterier för denna litteraturstudie bestämdes utifrån studiens frågeställningar och syfte. Författarna valde att enbart inkludera studier publicerade mellan 2005–2025. Detta för att uppnå en balans mellan aktuell forskning men samtidigt inte exkludera äldre studier inom området. Då forskning om fysioterapeutiska interventioner vid

PPD var relativt begränsad ansågs det relevant att även inkludera äldre studier. Det kan däremot ses som en begränsning att inkludera äldre studier, då dessa studier kan ha utgått från tidigare riktlinjer och kan skilja sig från dagens praxis. Detta bör beaktas vid tolkning av resultat och dess generaliserbarhet (SBU, 2024a). Vidare inkluderades endast studier på engelska, då författarnas språkkunskaper var begränsad. Detta kan ha lett till att relevanta studier publicerade på andra språk exkluderats, vilket kan tolkas som en begränsning och risk för språkbias för denna litteraturstudie (SBU, 2024a). Generaliserbarheten kan ha påverkats av denna begränsning eftersom PPD är globalt forskningsområde och kan ha studerats i icke-engelsktalande länder. Studier som inkluderade mer än en fysioterapeutisk intervention exkluderades. Detta för att minska risken för confounding variables, vilket säkerställde en separat redovisning av interventionernas effekt och därmed kunde resultatet utvärderas tydligare (Jager et al., 2008). Detta möjliggjorde även en säkrare bedömning av interventionens specifika biopsykosociala effekter.

För att strukturera frågeställningen tillämpades PICO-verktyget. Genom att tillämpa PICO kunde inklusions- och exklusionskriterier bestämmas men även formulera strukturerade sökningar. En begränsning med att outcome (O) och comparison (C) exkluderats från PICO-ramverket är att sökstrategierna blev mindre preciserade, vilket ledde till en ökad variation i utformning och utfallsmått i de inkluderade studierna. Utan ett tydligt utfallsmått (O) i sökningarna blev det svårare att jämföra studierna och dra tydliga slutsatser kring effekten av interventionerna. Däremot om PICO inte används kan det bli problematiskt att återfinna huvudbegrepp för sökningarna och därmed svårt att inkludera lämpliga studier, därför anses det som en styrka att denna litteraturstudie använt PICO-ramverket (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, 2025).

De relevanta söktermerna identifierades genom MeSH-termer inom postpartum och fysioterapeutiska interventioner och användes både som fritextord samt mesh-termer för att öka sökträffarna. Författarna fick även hjälp av bibliotekarie på Mälardalens universitet för att ta fram breda sökningar. Trots försöket att hitta breda sökningar kan sökstrategin varit för smal med tanke på bredden av fysioterapeutiska interventioner, vilket kan ha lett till att relevanta studier inte identifierades. Vidare hade ingen i författarparet tidigare erfarenhet av att göra en relevansbedömning eller kvalitetsgranskning vilket innebar en bristfällig kvalitet på bedömningen som påverkade studiens trovärdighet. Författarna har däremot utgått från valida och reliabla bedömningsmallar vilket är något som stärker studiens interna validitet, och därigenom ökar trovärdigheten och minskar risk för mätfel hos studien och är därmed en metodologisk styrka hos studien. Det finns också begränsningar med att använda standardiserade bedömningsmallar, då dessa kan vara utformade för en mer experimentell studiedesign så som läkemedelsstudier där kontrollgruppen kan vara blindad. Detta bör beaktas vid tolkning av resultatet.

I denna litteraturstudie användes inte GRADE för att bedöma evidensstyrkan, vilket kan ses som en begränsning. GRADE är främst utvecklat för systematiska översikter och inte ett krav på kandidatnivå, men användning av detta system hade kunnat stärka bedömningen av evidensstyrkan. Istället användes preliminär evidensstyrka för att sammanfatta

evidensstyrkan, vilket i stora drag bygger på liknande principer som GRADE. Däremot är det en mindre etablerad metod vilket gör att resultatet bör tolkas med viss försiktighet (SBU, 2022b).

5.4 Etikdiskussion

Alla studier som inkluderats i denna studie har blivit etiskt godkända vilket stärker trovärdigheten av de inkluderade studierna, och anses extra viktigt när populationen som forskas på är sårbar. Utöver den formella etiska granskningen är det också viktigt att uppmärksamma urvalet och överförbarheten av resultatet från studierna. Samtliga inkluderade studier kommer från Turkiet, USA, Storbritannien och Kanada. Detta begränsar överförbarheten av resultaten till andra geografiska och kulturella kontexter som exempelvis kvinnor i låginkomstländer eller regioner med sämre tillgång till postpartumvård. Deltagarna i studierna utgjordes dessutom främst av kvinnor med i övrigt god hälsa och viss aktivitetsnivå. Detta innebär att de kvinnor som drabbats av exempelvis förlossningskomplikationer eller andra komplexa besvär i populationen inte blir representerade. Det finns därför en risk att resultatet inte är överförbart till hela populationen med PPD utan endast de kvinnor som liknar urvalet. Ur ett etiskt perspektiv är det även viktigt att belysa potentiella risker med fysisk aktivitet som intervention för postpartumkvinnor med PPD. Fysisk aktivitet och träning kan innebära risker för fysiska skador eller överbelastning. Kvinnorna kan också uppleva en ökad press gällande utförande av fysisk aktivitet för att förbättra tillståndet, uppnå vissa träningsmål vilket kan leda till en ökad stress och skam hos kvinnorna om man inte uppnår målen. Därav är det viktigt att individanpassa och stegra interventionen successivt för att anpassa efter den enskilda kvinnans förutsättning gällande exempelvis motivation och energinivå, och därigenom ta hänsyn till de etiska principerna i utformandet av träningsupplägget.

6 SLUTSATSER

Denna litteraturstudie visar att fysioterapeutiska interventioner i form av olika typer av fysisk aktivitet kan bidra till minskade depressiva symtom hos kvinnor med PPD. Samtidigt visade tre av sex studier icke-signifikanta skillnader i depressiva symtom i mellangruppsjämförelse, vilket betyder att evidens för interventionernas effekt inte är samstämmig och att resultatet bör tolkas med försiktighet. Flera interventioner utfördes på måttlig intensitet, vilket kan vara tillräckligt för kliniskt relevanta effekter, vilket tyder på att dos och följsamhet är centrala faktorer för förbättringar av depressiva symtom. Vidare visades en biopsykosocial effekt inom interventionsgrupperna där socialt stöd och self-efficacy tros minska symtomen,

även om detta inte konsekvent har undersökts som primärt utfallsmått. Den genomgående höga risken för bias och den begränsade geografiska spridningen, leder till att resultatet och generaliserbarheten bör tolkas med viss försiktighet och främst kan översättas till länder med liknande förutsättningar. Kunskapsluckan är delvis besvarad men vidare forskning krävs gällande hur komplikationer, förlossningssätt och samsjuklighet påverkar biopsykosociala aspekter vid PPD. Denna studie understryker bristen på studier med primära biopsykosociala utfallsmått där vidare forskning krävs för att kunna dra säkrare slutsatser.

7 KLINISK BETYDELSE OCH VIDARE FORSKNING

Studiens resultat bidrar till ökad kunskap om fysioterapeutiska interventioners biopsykosociala effekter vid postpartum depression såsom minskade depressiva symtom. Fysioterapeuter som kommer att behandla kvinnor med PPD bör prioritera fysisk aktivitet på måttlig intensitet med god följsamhet. Biopsykosociala faktorer som self-efficacy och socialt stöd bör beaktas och främjas för trolig effekt på depressiva symtom. Samtidigt belyser resultaten en brist på studier med hög kvalitet och beskrivna interventioner samt bredare geografisk spridning vilket begränsar generaliserbarheten och tolkningen av resultatet. Detta betonar behovet av vidare forskning inom området, framför allt gällande hur komplikationer, förlossningssätt och samsjuklighet påverkar biopsykosociala aspekter vid PPD. Denna studie tydliggör betydelsen av fysioterapeuternas roll inom vård och behandlingen av PPD. Vilket understryker vikten av att tillämpa fysisk aktivitet och beteendestöd i det multiprofessionella omhändertaget av kvinnor med PPD.

REFERENSLISTA

Ahmadinezhad, G. S., Karimi, F. Z., Abdollahi, M., & NaviPour, E. (2024). Association between postpartum depression and breastfeeding self-efficacy in mothers: a systematic review and meta-analysis. *BMC pregnancy and childbirth*, *24*(1), 273. https://doi.org/10.1186/s12884-024-06465-4

Baker J. D. (2016). *The Purpose, Process, and Methods of Writing a Literature Review. AORN journal*, *103*(3), 265–269. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.aorn.2016.01.016

Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: a social cognitive theory*. Prentice-Hall.

Bardage, C., Isacson, D., Ring, L., & Bingefors, K. (2003). A Swedish population-based study on the relationship between the SF-36 and health utilities to measure health in hypertension. *Blood pressure*, *12*(4), 203–210. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1080/08037050310002083

Buttner, M. M., Brock, R. L., O'Hara, M. W., & Stuart, S. (2015). Efficacy of yoga for depressed postpartum women: A randomized controlled trial. *Complementary therapies in clinical practice*, *21*(2), 94–100. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2015.03.003

Charles Sturt University. (10 februari 2025). *HIP202 Research Skills Guide: PubMed*. *https://libguides.csu.edu.au/hip202/pubmed*

Cho, H., Lee, K., Choi, E., Cho, H. N., Park, B., Suh, M., Rhee, Y., & Choi, K. S. (2022). Association between social support and postpartum depression. *Scientific reports*, *12*(1), 3128. https://doi.org/10.1038/s41598-022-07248-7

Da Costa, D., Lowensteyn, I., Abrahamowicz, M., Ionescu-Ittu, R., Dritsa, M., Rippen, N., Cervantes, P., & Khalifé, S. (2009). A randomized clinical trial of exercise to alleviate postpartum depressed mood. *Journal of psychosomatic obstetrics and gynaecology*, *30*(3), 191–200. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1080/01674820903212136

Daley, A., Winter, H., Grimmett, C., McGuinness, M., McManus, R., & MacArthur, C. (2008). Feasibility of an exercise intervention for women with postnatal depression: a pilot randomised controlled trial. *The British journal of general practice : the journal of*

the Royal College of General Practitioners, *58*(548), 178–183. https://doi.org/10.3399/bjgp08x277195

de Manincor, M., Bensoussan, A., Smith, C. A., Barr, K., Schweickle, M., Donoghoe, L. L., Bourchier, S., & Fahey, P. (2016). INDIVIDUALIZED YOGA FOR REDUCING DEPRESSION AND ANXIETY, AND IMPROVING WELL-BEING: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. *Depression and anxiety*, *33*(9), 816–828. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1002/da.22502

Dekker, J., Stauder, A., & Penedo, F. J. (2017). Proposal for an Update of the Definition and Scope of Behavioral Medicine. *International journal of behavioral medicine*, *24*(1), 1–4. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1007/s12529-016-9610-7

Denison, E., & Åsenlöf, P. (2012). *Beteendemedicinska tillämpningar i sjukgymnastik* (1:auppl.). Studentlitteratur.

Dennis, C. L., Ravitz, P., Grigoriadis, S., Jovellanos, M., Hodnett, E., Ross, L., & Zupancic, J. (2012). The effect of telephone-based interpersonal psychotherapy for the treatment of postpartum depression: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials*, *13*, 38. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1186/1745-6215-13-38

Dennis, C. L., Singla, D. R., Brown, H. K., Savel, K., Clark, C. T., Grigoriadis, S., & Vigod, S. N. (2024). Postpartum Depression: A Clinical Review of Impact and Current Treatment Solutions. *Drugs*, *84*(6), 645–659. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1007/s40265-024-02038-z

Deprato, A., Ruchat, S. M., Ali, M. U., Cai, C., Forte, M., Gierc, M., Meyer, S., Sjwed, T. N., Shirazi, S., Matenchuk, B. A., Jones, P. A. T., Sivak, A., & Davenport, M. H. (2025). Impact of postpartum physical activity on maternal depression and anxiety: a systematic review and meta-analysis. *British journal of sports medicine*, *59*(8), 550–561. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1136/bjsports-2024-108478

Dritsa, M., Da Costa, D., Dupuis, G., Lowensteyn, I., & Khalifé, S. (2008). Effects of a home-based exercise intervention on fatigue in postpartum depressed women: results of a randomized controlled trial. *Annals of behavioral medicine : a publication of the Society of Behavioral Medicine*, *35*(2), 179–187. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1007/s12160-008-9020-4

Forsyth, J., Boath, E., Henshaw, C., & Brown, H. (2017). Exercise as an adjunct treatment for postpartum depression for women living in an inner city—A pilot study. *Health Care for Women International*, *38*(6), 635–639. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1080/07399332.2017.1295049

FYSS. (2016). *Fysisk aktivitet – begrepp och definitioner*. (Version 2016–12). https://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FA_Begrepp-och-definitioner_FINAL_2016-12.pdf

FYSS. (2021). *Graviditet: Rekommendationer* (Version 2021-10). https://www.fyss.se/wp-content/uploads/2021/10/Rek-gravida.pdf

Gerbasi, M. E., Eldar-Lissai, A., Acaster, S., Fridman, M., Bonthapally, V., Hodgkins, P., Kanes, S. J., & Meltzer-Brody, S. (2020). Associations between commonly used patient-reported outcome tools in postpartum depression clinical practice and the Hamilton Rating Scale for Depression. *Archives of women's mental health*, *23*(5), 727–735. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1007/s00737-020-01042-y

Goldberg, J. H., Breckenridge, J. N., & Sheikh, J. I. (2003). Age differences in symptoms of depression and anxiety: examining behavioral medicine outpatients. *Journal of behavioral medicine*, *26*(2), 119–132. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1023/a:1023030605390

Gorman, L. L., O'Hara, M. W., Figueiredo, B., Hayes, S., Jacquemain, F., Kammerer, M. H., Klier, C. M., Rosi, S., Seneviratne, G., Sutter-Dallay, A. L., & TCS-PND Group (2004). Adaptation of the structured clinical interview for DSM-IV disorders for assessing depression in women during pregnancy and post-partum across countries and cultures. *The British journal of psychiatry. Supplement*, *46*, s17–s23. https://doi.org/10.1192/bjp.184.46.s17

Govindaraj, R., Karmani, S., Varambally, S., & Gangadhar, B. N. (2016). Yoga and physical exercise - a review and comparison. *International review of psychiatry (Abingdon, England)*, *28*(3), 242–253. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.3109/09540261.2016.1160878

Graneheim, U. H., Lindgren, B. M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. *Nurse education today*, *56*, 29–34. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/28651100/

Hagelin, C. L., Wengström, Y., Runesdotter, S., & Fürst, C. J. (2007). The psychometric properties of the Swedish Multidimensional Fatigue Inventory MFI-20 in four different populations. *Acta oncologica (Stockholm, Sweden)*, *46*(1), 97–104. https://doi.org/10.1080/02841860601009430

Jager, K. J., Zoccali, C., Macleod, A., & Dekker, F. W. (2008). Confounding: what it is and how to deal with it. *Kidney international*, *73*(3), 256–260. https://doi.org/10.1038/sj.ki.5002650

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (29 augusti 2023) *Grå litteratur*. https://kib.ki.se/soka-vardera/gra-litteratur

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket. (13 december 2024). *Användbara databaser och webbplatser*. *https://kib.ki.se/soka-vardera/soka-information/anvandbara-databaser-och-webbplatser*

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket. (20 januari 2025*). Systematisk litteraturöversikt som examensarbete*. https://kib.ki.se/soka-vardera/systematiska-oversikter-forskare/systematisk-litteraturoversikt-som-examensarbete

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket. (7 augusti 2023). *Redovisa en sökning*. https://kib.ki.se/soka-vardera/soka-information/redovisa-en-sokning

Li, X., Laplante, D. P., Paquin, V., Lafortune, S., Elgbeili, G., & King, S. (2022). Effectiveness of cognitive behavioral therapy for perinatal maternal depression, anxiety and stress: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Clinical psychology review*, *92*, 102129. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.cpr.2022.102129

Liu, H. L., Sun, J., Meng, S. F., & Sun, N. (2024). Physiotherapy for patients with depression: Recent research progress. *World journal of psychiatry*, *14*(5), 635–643.

Lunds universitet. (14 januari 2016). *Att söka vetenskapliga artiklar – En vägledning i systematisk litteratursökning*. *https://www.medicin.lu.se/sites/medicin.lu.se/files/informationssokning2016.pd*

Machalicek, W., Gross, D. P., Armijo-Olivo, S., Ferriero, G., Kiekens, C., Martin, R., Walshe, M., Negrini, S., & 5th Cochrane Rehabilitation Methodological Meeting participants (2024). The role of single case experimental designs in evidence creation in rehabilitation. *European journal of physical and rehabilitation medicine*, *60*(6), 1100–1111. https://doi.org/10.23736/S1973-9087.24.08713-6

Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC medical research methodology*, *18*(1), 143. https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x

Nessen, T., Demmelmaier, I., Nordgren, B., & Opava, C. H. (2015). The Swedish Exercise Self-Efficacy Scale (ESES-S): reliability and validity in a rheumatoid arthritis population. *Disability and rehabilitation*, *37*(22), 2130–2134. https://doi.org/10.3109/09638288.2014.998780

Park, S. H., & Kim, J. I. (2023). Predictive validity of the Edinburgh postnatal depression scale and other tools for screening depression in pregnant and postpartum women: a systematic review and meta-analysis. *Archives of gynecology and obstetrics*, *307*(5), 1331–1345. https://doi.org/10.1007/s00404-022-06525-0

Posadzki, P., & Parekh, S. (2009). Yoga and physiotherapy: a speculative review and conceptual synthesis. *Chinese journal of integrative medicine*, *15*(1), 66–72. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1007/s11655-009-0066-0

Qi, W., Wang, Y., Wang, Y., Huang, S., Li, C., Jin, H., Zuo, J., Cui, X., Wei, Z., Guo, Q., & Hu, J. (2025). Prediction of postpartum depression in women: development and validation of multiple machine learning models. *Journal of translational medicine*, *23*(1), 291. https://doi.org/10.1186/s12967-025-06289-6

Ross, L. E., Gilbert Evans, S. E., Sellers, E. M., & Romach, M. K. (2003). Measurement issues in postpartum depression part 2: assessment of somatic symptoms using the Hamilton Rating Scale for Depression. *Archives of women's mental health*, *6*(1), 59–64. https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.1007/s00737-002-0156-0

Sandborgh, M., Dean, E., Denison, E., Elvén, M., Fritz, J., Wågert, P. von H., … Söderlund, A. (2018). *Integration of behavioral medicine competencies into physiotherapy curriculum in an exemplary Swedish program: rationale, process, and review.*https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09593985.2018.1488192#abstract

SBU- Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2020). Manual till mallar för randomiserande och icke randomiserande kontrollerande studier interventionsstudier. https://www.sbu.se/globalassets/ebm/manual_mallarna_randomiserade_icke-randomiserade_kontrollerade_studier.pdf

SBU- Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2024b). *Granskningsmallar*. https://www.sbu.se/sv/granskningsmallar/.

SBU- Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). *Litteratursökning* https://www.sbu.se/contentassets/0a957751db6e4dfc9ab752411366ae0d/sbushandbok_kapitel04.pdf

SBU-Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2022a). *Psykologisk behandling av postpartumdepression*. https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/psykologisk-behandling-av-postpartumdepression/

SBU-Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2022b). *Vetenskap & praxis*. https://www.sbu.se/sv/publikationer/nya-vetenskap-och-praxis/sammanfattas-forskningen-ratt/ ¨

SBU-Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2024a). *Utvärdering av insatser i hälso- och sjukvården och socialtjänsten*. En metodbok. https://www.sbu.se/metodbok?pub=48286#101443

Slomian, J., Honvo, G., Emonts, P., Reginster, J. Y., & Bruyère, O. (2019). Consequences of maternal postpartum depression: A systematic review of maternal and infant outcomes. *Women's health (London, England)*, *15*, 1745506519844044. https://doi.org/10.1177/1745506519844044

Stewart, D. E., & Vigod, S. N. (2019). Postpartum Depression: Pathophysiology, Treatment, and Emerging Therapeutics. *Annual review of medicine*, *70*, 183–196. https://doi.org/10.1146/annurev-med-041217-011106.

Sullivan, G. M., & Feinn, R. (2012). Using Effect Size-or Why the P Value Is Not Enough. *Journal of graduate medical education*, *4*(3), 279–282. https://doi.org/10.4300/JGME-D-12-00156.1

Karolinska Institutet. (u.å.). *Svensk MeSH*. https://mesh.kib.ki.se/Mesh/search/?searchterm=anhedoni

Szota, M., Rogowska, A. M., Kwaśnicka, A., & Chilicka-Hebel, K. (2024). The Indirect Effect of Future Anxiety on the Relationship between Self-Efficacy and Depression in a Convenience Sample of Adults: Revisiting Social Cognitive Theory. *Journal of clinical medicine*, *13*(16), 4897. https://doi.org/10.3390/jcm13164897

Vetenskapsrådet. (2002). *Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning*. https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf

Walker, A. L., de Rooij, S. R., Dimitrova, M. V., Witteveen, A. B., Verhoeven, C. J., de Jonge, A., Vrijkotte, T. G. M., & Henrichs, J. (2021). Psychosocial and peripartum determinants of postpartum depression: Findings from a prospective population-based cohort. The ABCD study. *Comprehensive psychiatry*, *108*, 152239. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2021.152239

Watson, D., O'Hara, M. W., Simms, L. J., Kotov, R., Chmielewski, M., McDade-Montez, E. A., Gamez, W., & Stuart, S. (2007). Development and validation of the Inventory of Depression and Anxiety Symptoms (IDAS). *Psychological assessment*, *19*(3), 253–268. https://doi.org/10.1037/1040-3590.19.3.253

World Medical Association. (2013). WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects.https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/

Xu, H., Liu, R., Wang, X., & Yang, J. (2023). Effectiveness of aerobic exercise in the prevention and treatment of postpartum depression: Meta-analysis and network

meta-analysis. *PloS one*, *18*(11), e0287650. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0287650

Zabor, E. C., Kaizer, A. M., & Hobbs, B. P. (2020). Randomized Controlled Trials. *Chest*, *158*(1S), S79–S87. https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.ep.bib.mdh.se/32658656

Özkan, S. A., Kücükkelepce, D. S., Korkmaz, B., Yılmaz, G., & Bozkurt, M. A. (2020). The effectiveness of an exercise intervention in reducing the severity of postpartum depression: A randomized controlled trial. Perspectives in Psychiatric Care., 56(4), 844–850. https://doi.org/10.1111/ppc.12500

BILAGA A- SBU:S MALL FÖR RELEVANSBEDÖMNING

Bilaga 1. **Mall för bedömning av relevans**

REVIDERAD 2014

Författare: _____ År: _____ Artikelnummer: _____

1. Studiepopulation	**Ja**	**Nej**	**Oklart**	**Ej tillämpl**
a) Är den population som deltagarna togs från tydligt beskriven och relevant?	☐	☐	☐	☐
b) Är sättet att rekrytera deltagare acceptabelt?	☐	☐	☐	☐
c) Är studiens inklusionskriterier adekvata?	☐	☐	☐	☐
d) Är studiens exklusionskriterier adekvata? [1]	☐	☐	☐	☐

2. Undersökt intervention	**Ja**	**Nej**	**Oklart**	**Ej tillämpl**
a) Är den undersökta interventionen relevant? [2]	☐	☐	☐	☐
b) Är den undersökta interventionen administrerad/utförd på ett korrekt sätt? [3]	☐	☐	☐	☐
c) Är den undersökta interventionen administrerad/utförd på ett reproducerbart sätt? [4]	☐	☐	☐	☐

3. Jämförelseintervention	**Ja**	**Nej**	**Oklart**	**Ej tillämpl**
a) Är jämförelseinterventionen relevant? [5]	☐	☐	☐	☐
b) Kan man utesluta att val av jämförelse-intervention, dos eller administrationssätt/utförande medfört ett systematiskt fel till förmån för endera interventionen?	☐	☐	☐	☐

4. Effektmått	**Ja**	**Nej**	**Oklart**	**Ej tillämpl**
a) Har undersökta effektmått klinisk relevans?	☐	☐	☐	☐

5. Studielängd [6]	**Ja**	**Nej**	**Oklart**	**Ej tillämpl**
a) Är studiens längd adekvat?	☐	☐	☐	☐
b) Är uppföljningstiden adekvat?	☐	☐	☐	☐

Total bedömning av studierelevans

Relevant ☐ Inte relevant ☐

BILAGA B- ROB2

Bedömning av risk för bias i randomiserade kontrollerade studier (RCT)

UPPDATERAD 2024-02-13

Uppgifter om den studie som bedömts		
Referens-ID: Författare och publiceringsår:		
Uppgifter om bedömningen		
Vilket eller vilka utfall har bedömts? Vilken typ av effekt har bedömts?	Att ha allokerats till en intervention ☐	Att ha fullföljt en intervention ☐
Vem har granskat studien?		
Namn:		

Screeningfrågor	Nej/oklart	Ja
1. Är randomiseringen till grupperna otillfredsställande utförd? (gäller både proceduren och utfallet vid baslinjemätningen)	☐	☐
2. Finns det något övrigt skäl att ta bort studien från vidare granskning (till exempel orimliga resultat, olämplig publikationskanal, stark misstanke om oredlighet i forskningen)?	☐	☐
Motivering:		
Tillägg av SBU		

Övergripande bedömning av risk för bias	Låg	Måttlig	Hög	Oacceptabelt hög
Gör en bedömning baserad på samtliga domäner 1–6: Hur bedömer du den sammantagna risken för att resultaten i studien kan vara missvisande på grund av bias?	☐	☐	☐	☐
Motivering:				
Modifierad av SBU				

Stöd för bedömningen finns i dokumentet *Manual för bedömning av risk för bias i randomiserade kontrollerade studier (RCT).* Där finns förtydliganden av begrepp och rekommendationer angående arbetsprocessen.

1. Risk för bias på grund av randomiseringsprocessen

		Ja	Troligen	Troligen inte	Nej	Oklart
1.1	Var allokeringssekvensen slumpmässigt genererad?	☐	☐	☐	☐	☐
1.2	Var allokeringssekvensen dold innan deltagarna delades in i grupper?	☐	☐	☐	☐	☐
1.3	Fanns det skillnader i baslinjevärden mellan grupperna som tyder på brister i randomiseringsprocessen?	☐	☐	☐	☐	☐
Samlad bedömning av risken för bias		**Låg**	**Måttlig**	**Hög**	**Oacceptabelt hög**	
		☐	☐	☐	☐	

Kommentar:

2. Risk för bias på grund av avvikelser från den avsedda interventionen

Frågorna besvaras i enlighet med intentionen för bedömningen: att undersöka effekten av att ha allokerats till en intervention (ITT) eller effekten av att ha fullföljt en intervention (PP). Besvara därför antingen frågorna i sektion 2A eller de i sektion 2B inför den sammanvägda bedömningen av domänen.

2A. Besvaras om intentionen är att undersöka effekten av att ha allokerats till en intervention

		Ja	Troligen	Troligen inte	Nej	Oklart
2.1	Var deltagarna i studien medvetna om sin grupptillhörighet?	☐	☐	☐	☐	☐
2.2	Var de som gav interventionen (behandlarna) medvetna om vilken grupp studiedeltagarna tillhörde?	☐	☐	☐	☐	☐

- ***Nej/Troligen inte på 2.1 och 2.2:*** *Gå vidare till fråga 2.6*
- ***Ja/Troligen/Oklart på 2.1 eller 2.2:*** *Besvara även fråga 2.3.*

2.3	Förekom några avvikelser från interventionsplanen – utöver sådana som normalt kan inträffa i verksamheten?	☐	☐	☐	☐	☐

- ***Nej/Troligen inte/Oklart:*** *Gå vidare till fråga 2.6*
- ***Ja/Troligen:*** *Besvara även fråga 2.4.*

2.4	Finns det skäl att misstänka att avvikelserna har påverkat utfallet?	☐	☐	☐	☐	☐

- ***Nej/Troligen inte:*** *Gå vidare till fråga 2.6*
- ***Ja/Troligen/Oklart:*** *Besvara även fråga 2.5.*

2.5	Var avvikelserna jämnt fördelade mellan grupperna?	☐	☐	☐	☐	☐

3. Risk för bias på grund av bortfall

		Ja	Troligen	Troligen inte	Nej	Oklart
3.1	Har resultat redovisats för alla eller nästan alla deltagare som randomiserats?	☐	☐	☐	☐	☐

- ***Nej/Troligen inte/ Oklart:*** *Besvara även fråga 3.2.*
- ***Ja/Troligen:*** *Gör en sammanvägd bedömning av risken för bias direkt*

3.2	Finns det belägg för att resultatet inte snedvridits på grund av bortfall?	☐	☐	☐	☐	☐

- ***Nej/Troligen inte:*** *Besvara även fråga 3.3.*
- ***Ja/Troligen/Oklart:*** *Gör en sammanvägd bedömning av risken för bias direkt*

3.3	Kan det sanna mätvärdet för resultatet vara en möjlig orsak till bortfall?	☐	☐	☐	☐	☐

- ***Nej/Troligen inte:*** *Gör en sammanvägd bedömning av risken för bias direkt*
- ***Ja/Troligen/Oklart:*** *Besvara även fråga 3.4.*

3.4	Är det sannolikt att det sanna mätvärdet för resultatet är orsak till bortfall?	☐	☐	☐	☐	☐

Samlad bedömning av risken för bias	**Låg**	**Måttlig**	**Hög**	**Oacceptabelt hög**
	☐	☐	☐	☐

Kommentar:

4. Risk för bias på grund av hur utfallen har mätts

		Ja	Troligen	Troligen inte	Nej	Oklart
4.1	Användes en olämplig metod för att mäta utfallet?	☐	☐	☐	☐	☐
4.2	Kan metoderna för utfallsmätning ha skiljt sig åt mellan grupperna??	☐	☐	☐	☐	☐

- Om svaret frågorna 4.1 och 4.2 är ***Nej/Troligen inte/Oklart,*** *besvara även fråga 4.3:*
- ***I annat fall:*** *Gör en sammanvägd bedömning av risken för bias direkt*

4.3	Var de som bedömde utfallet medvetna om vilken intervention deltagarna fått?	☐	☐	☐	☐	☐

- ***Nej/Troligen inte:*** *Gör en sammanvägd bedömning av risken för bias direkt*
- ***Ja/Troligen/Oklart:*** *Besvara även fråga 4.4.*

4.4	Kan utfallsmåttet ha påverkats av kännedom om erhållen intervention?	☐	☐	☐	☐	☐

- ***Nej/Troligen inte:*** *Gör en sammanvägd bedömning av risken för direkt*
- ***Ja/Troligen/Oklart:*** *Besvara även fråga 4.5.*

4.5	Är det troligt att mätningen av utfallet påverkats av kännedom om grupptillhörighet?	☐	☐	☐	☐	☐

Samlad bedömning av risken för bias	**Låg**	**Måttlig**	**Hög**	**Oacceptabelt hög**
	☐	☐	☐	☐

Kommentar:

5. Risk för bias på grund av selektiv rapportering av resultat					
	Ja	**Troligen**	**Troligen inte**	**Nej**	**Oklart**
5.1 Var analyserna genomförda enligt en plan som publicerats innan utfallsdata var tillgängliga?	☐	☐	☐	☐	☐
Kan det rapporterade effektestimatet ha valts, utifrån kännedom om resultaten, bland…					
5.2 …flera olika sätt att mäta utfallet? (t.ex. olika skalor, definitioner, tidpunkter)	☐	☐	☐	☐	☐
5.3 …flera möjliga sätt att analysera data?	☐	☐	☐	☐	☐
Samlad bedömning av risken för bias	**Låg**	**Måttlig**	**Hög**	**Oacceptabelt hög**	
	☐	☐	☐	☐	
Kommentar:					

6. Risk för bias på grund av intressekonflikter		
	Ja	**Nej**
6.1 Deklarerar författarna att de saknar finansiella intressen som kan påverka utfallet?	☐	☐
6.2 Deklarerar författarna att de saknar andra bindningar som kan påverka utfallet?	☐	☐
Kommentar:		
Tillägg av SBU		

Våra sökningar	Pub Meds filtreringar och skapning av Mesh termer
("postpartum depression" OR "postnatal depression" OR "Postpartum dysphoria") AND (exercise* OR physical activity* OR yoga OR training) AND (intervention OR therapy OR program OR trial) NOT (prevention OR perinatal)	((("postpartum depression"[All Fields] OR "postnatal depression"[All Fields] OR "Postpartum dysphoria"[All Fields]) AND ("exercise*"[All Fields] OR (("physical examination"[MeSH Terms] OR ("physical"[All Fields] AND "examination"[All Fields]) OR "physical examination"[All Fields] OR "physical"[All Fields] OR "physically"[All Fields] OR "physicals"[All Fields]) AND "activity*"[All Fields]) OR ("yoga"[MeSH Terms] OR "yoga"[All Fields]) OR ("education"[MeSH Subheading] OR "education"[All Fields] OR "training"[All Fields] OR "education"[MeSH Terms] OR "train"[All Fields] OR "train s"[All Fields] OR "trained"[All Fields] OR "training s"[All Fields] OR "trainings"[All Fields] OR "trains"[All Fields])) AND ("intervention s"[All Fields] OR "interventions"[All Fields] OR "interventive"[All Fields] OR "methods"[MeSH Terms] OR "methods"[All Fields] OR "intervention"[All Fields] OR "interventional"[All Fields] OR ("therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All Fields] OR "therapies"[All Fields] OR "therapy"[MeSH Subheading] OR "therapy"[All Fields] OR "therapy s"[All Fields] OR "therapys"[All Fields]) OR ("program"[All Fields] OR "program s"[All Fields] OR "programe"[All Fields] OR "programed"[All Fields] OR "programes"[All Fields] OR "programing"[All Fields] OR "programmability"[All Fields] OR "programmable"[All Fields] OR "programmably"[All Fields] OR

	"programme"[All Fields] OR "programme s"[All Fields] OR "programmed"[All Fields] OR "programmer"[All Fields] OR "programmer s"[All Fields] OR "programmers"[All Fields] OR "programmes"[All Fields] OR "programming"[All Fields] OR "programmings"[All Fields] OR "programs"[All Fields]) OR ("clinical trials as topic"[MeSH Terms] OR ("clinical"[All Fields] AND "trials"[All Fields] AND "topic"[All Fields]) OR "clinical trials as topic"[All Fields] OR "trial"[All Fields] OR "trial s"[All Fields] OR "trialed"[All Fields] OR "trialing"[All Fields] OR "trials"[All Fields])))) NOT ("prevent"[All Fields] OR "preventability"[All Fields] OR "preventable"[All Fields] OR "preventative"[All Fields] OR "preventatively"[All Fields] OR "preventatives"[All Fields] OR "prevented"[All Fields] OR "preventing"[All Fields] OR "prevention and control"[MeSH Subheading] OR ("prevention"[All Fields] AND "control"[All Fields]) OR "prevention and control"[All Fields] OR "prevention"[All Fields] OR "prevention s"[All Fields] OR "preventions"[All Fields] OR "preventive"[All Fields] OR "preventively"[All Fields] OR "preventives"[All Fields] OR "prevents"[All Fields] OR ("perinatal"[All Fields] OR "perinatally"[All Fields] OR "perinatals"[All Fields])))) AND ((randomizedcontrolledtrial[Filter]) AND (english[Filter]) AND (2005:2025[pdat]))

(postpartum depression[Title]) AND (exercise OR training)	("postpartum depression"[Title] AND ("exercise"[MeSH Terms] OR "exercise"[All Fields] OR "exercises"[All Fields] OR "exercise therapy"[MeSH Terms] OR ("exercise"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "exercise therapy"[All Fields] OR "exercising"[All Fields] OR "exercise s"[All Fields] OR "exercised"[All Fields] OR "exerciser"[All Fields] OR "exercisers"[All Fields] OR ("education"[MeSH Subheading] OR "education"[All Fields] OR "training"[All Fields] OR "education"[MeSH Terms] OR "train"[All Fields] OR "train s"[All Fields] OR "trained"[All Fields] OR "training s"[All Fields] OR "trainings"[All Fields] OR "trains"[All Fields]))) AND ((randomizedcontrolledtrial[Filter]) AND (english[Filter]) AND (2005:2025[pdat]))
("postpartum depression" OR "postnatal depression") AND ("exercise" OR "physical activity" OR "yoga" OR "training") AND ("intervention" OR "therapy" OR "program" OR "trial") NOT (prevention OR perinatal)	((("postpartum depression"[All Fields] OR "postnatal depression"[All Fields]) AND ("exercise"[All Fields] OR "physical activity"[All Fields] OR "yoga"[All Fields] OR "training"[All Fields]) AND ("intervention"[All Fields] OR "therapy"[All Fields] OR "program"[All Fields] OR "trial"[All Fields])) NOT ("prevent"[All Fields] OR "preventability"[All Fields] OR "preventable"[All Fields] OR "preventative"[All Fields] OR "preventatively"[All Fields] OR "preventatives"[All Fields] OR "prevented"[All Fields] OR "preventing"[All Fields] OR "prevention and control"[MeSH Subheading] OR ("prevention"[All Fields] AND "control"[All Fields]) OR "prevention and control"[All Fields] OR "prevention"[All Fields] OR "prevention s"[All Fields] OR

	"preventions"[All Fields] OR "preventive"[All Fields] OR "preventively"[All Fields] OR "preventives"[All Fields] OR "prevents"[All Fields] OR ("perinatal"[All Fields] OR "perinatally"[All Fields] OR "perinatals"[All Fields]))) AND ((randomizedcontrolledtrial[Filter]) AND (english[Filter]) AND (2005:2025[pdat]))
("postpartum depression" OR "postnatal depression" OR "Postpartum dysphoria") AND (exercise* OR physical activity* OR yoga OR training) AND (intervention OR therapy OR program OR trial)	(("postpartum depression"[All Fields] OR "postnatal depression"[All Fields] OR "Postpartum dysphoria"[All Fields]) AND ("exercise*"[All Fields] OR (("physical examination"[MeSH Terms] OR ("physical"[All Fields] AND "examination"[All Fields]) OR "physical examination"[All Fields] OR "physical"[All Fields] OR "physically"[All Fields] OR "physicals"[All Fields]) AND "activity*"[All Fields]) OR ("yoga"[MeSH Terms] OR "yoga"[All Fields]) OR ("education"[MeSH Subheading] OR "education"[All Fields] OR "training"[All Fields] OR "education"[MeSH Terms] OR "train"[All Fields] OR "train s"[All Fields] OR "trained"[All Fields] OR "training s"[All Fields] OR "trainings"[All Fields] OR "trains"[All Fields])) AND ("intervention s"[All Fields] OR "interventions"[All Fields] OR "interventive"[All Fields] OR "methods"[MeSH Terms] OR "methods"[All Fields] OR "intervention"[All Fields] OR "interventional"[All Fields] OR ("therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All Fields] OR "therapies"[All Fields] OR "therapy"[MeSH Subheading] OR "therapy"[All Fields] OR "therapy s"[All Fields] OR "therapys"[All

	Fields]) OR ("program"[All Fields] OR "program s"[All Fields] OR "programe"[All Fields] OR "programed"[All Fields] OR "programes"[All Fields] OR "programing"[All Fields] OR "programmability"[All Fields] OR "programmable"[All Fields] OR "programmably"[All Fields] OR "programme"[All Fields] OR "programme s"[All Fields] OR "programmed"[All Fields] OR "programmer"[All Fields] OR "programmer s"[All Fields] OR "programmers"[All Fields] OR "programmes"[All Fields] OR "programming"[All Fields] OR "programmings"[All Fields] OR "programs"[All Fields]) OR ("clinical trials as topic"[MeSH Terms] OR ("clinical"[All Fields] AND "trials"[All Fields] AND "topic"[All Fields]) OR "clinical trials as topic"[All Fields] OR "trial"[All Fields] OR "trial s"[All Fields] OR "trialed"[All Fields] OR "trialing"[All Fields] OR "trials"[All Fields]))) AND ((randomizedcontrolledtrial[Filter]) AND (english[Filter]) AND (2005:2025[pdat]))



Box 883, 721 23 Västerås **Tfn:** 021-10 13 00
Box 325, 631 05 Eskilstuna **Tfn:** 016-15 36 00
E-post: info@mdh.se **Webb:** www.mdu.se